



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI | 2020

PEDOMAN PELAYANAN ANTENATAL TERPADU

Edisi Ketiga

PEDOMAN PELAYANAN ANTENATAL TERPADU

Edisi Ketiga

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

618.24 Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Jenderal
Ind Kesehatan Masyarakat
p **Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu.—**
Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2020

ISBN 978-602-416-974-9

1. Judul

I. PRENATAL CARE

II. OBSTETRICS

KEMENKES RI

ISBN 978-602-416-974-9



KONTRIBUTOR

Penasehat:

dr. Kirana Pritasari, MQIH

Penanggung Jawab:

dr. Erna Mulati, M.Sc., CMFM

Tim Penyusun:

dr. Nida Rohmawati, MPH
dr. Achmad Zani Agusfar, SpOG (K)
dr. Dwirani Amelia, SpOG
dr. Mularsih Restianingrum, MKM
dr. Rima Damayanti, M. Kes
dr. Inti Mudjiati, MKM
dr. Milwiyandia, MARS
dr. Lina R. Mangaweang, SpKJ
dr. Karnely Helena, MKM
dr. Minerva Theodora Simatupang, MKM
dr. Lusy Levina
dr. Trijoko Yudopuspito, MScPH
dr. Sherli Karolina, MKM
dr. Dian Meutia Sari, M.Epid
dr. Ardiansyah Bahar, MKM

dr. Elvira Liyanto
dr. Bobby Marwal Syahrizal, MPH
dr. Karina Widowati
dr. Lukas C. Hermawan, M. Kes
dr. Muhammad Yusuf, MKM
dr. Ima Nuraina
dr. Yunita Rina Sari, MKM
dr. Stefani Christanti
Bintang Petralina, SST, M. Keb
Marlina Rully W., S. Gz
Windy Oktavina, SKM, M. Kes
Lasmaria Marpaung, SKM
Maylan Wulandari, SST, MKM
Esti Katherini Adhi, SST, MKM

Diterbitkan Oleh :

Kementerian Kesehatan RI

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik termasuk fotocopy rekaman dan lain-lain tanpa seijin tertulis dari penerbit.



KATA PENGANTAR

DIREKTUR KESEHATAN KELUARGA

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan buku “Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu” edisi revisi ini.

Berdasarkan data Sirkesnas 2016 cakupan K4 secara nasional sebesar 72,5%. Sedangkan cakupan layanan ANC 10T sangat rendah, yaitu 2,7%. Untuk komponen pemeriksaan laboratorium pada ibu hamil, tes golongan darah hanya 38,3%, sedangkan pemeriksaan protein urin 35,6 %. Pemberian tablet tambah darah 90 tablet hanya 34,8%. Data-data diatas menunjukkan masih rendahnya kualitas layanan ANC. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas layanan antenatal melalui pelaksanaan ANC terpadu dengan melibatkan lintas program. Dengan melakukan ANC terpadu yang sesuai standar diharapkan dapat menurunkan AKI dan AKN karena ibu hamil terdeteksi dari awal apabila terdapat faktor risiko atau komplikasi kehamilan dengan faktor risiko persalinan.

Pada tahun 2016, WHO telah mengeluarkan rekomendasi pelayanan antenatal yang bertujuan memberikan pengalaman hamil dan melahirkan yang positif (*positive pregnancy experience*) bagi para ibu. Kementerian Kesehatan melakukan adaptasi rekomendasi WHO yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu menerbitkan buku pedoman pelayanan antenatal terpadu yang disesuaikan dengan rekomendasi WHO tersebut. Buku pedoman ini merupakan revisi dari buku Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu edisi kedua tahun 2015. Pada pedoman ini juga disampaikan ANC dilaksanakan minimal 6 kali dimana pada ANC kunjungan pertama dokter akan melakukan skrining dan menangani faktor risiko kehamilan. Sedangkan pada kunjungan kelima di trimester 3 kehamilan, dokter melaksanakan skrining faktor risiko persalinan.

Terima kasih kepada UNICEF yang telah memberikan dukungan, juga kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Harapan saya, semoga pedoman ini dapat bermanfaat dalam menurunkan ibu dan bayi baru lahir di Indonesia. Kami menyadari bahwa pedoman ini belum sempurna, untuk itu masukan dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan pedoman ini di masa yang akan datang.

Direktur Kesehatan Keluarga



dr. Erna Mulati, MSc.CMFM

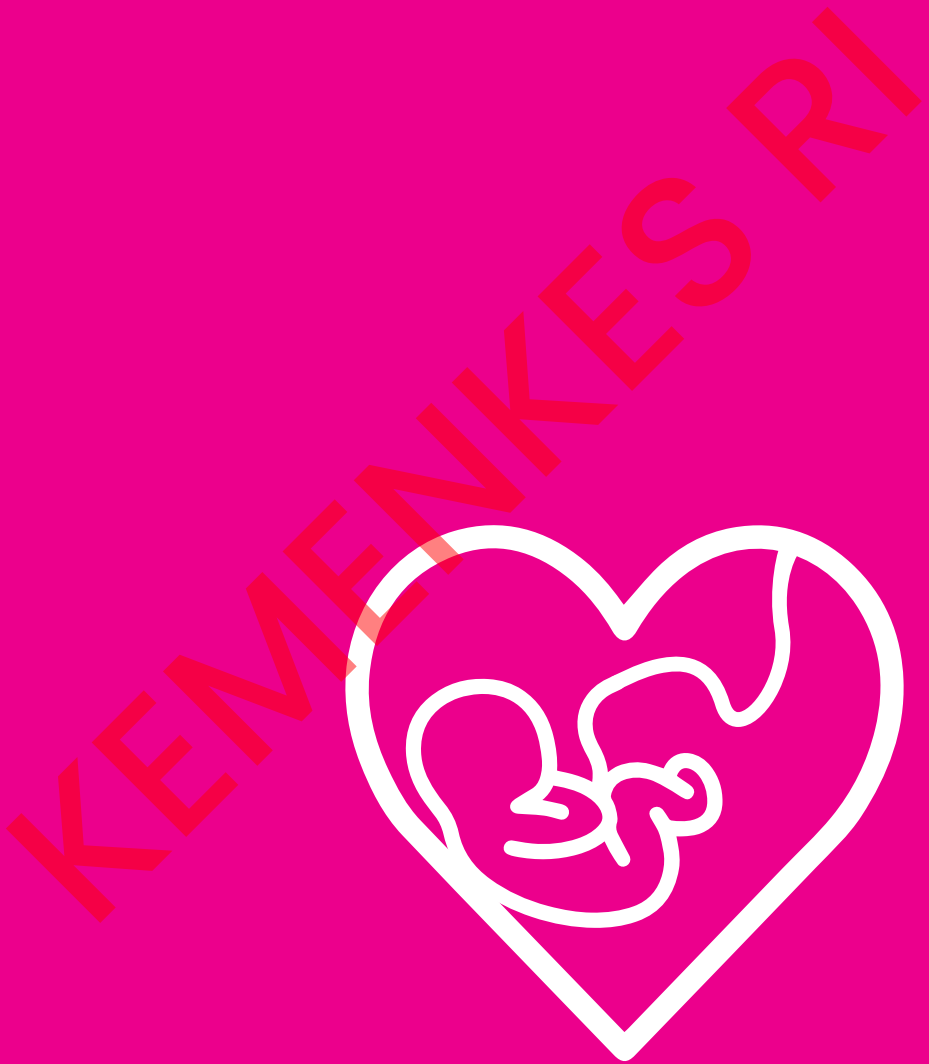
DAFTAR ISI

Kontributor	i
Kata Pengantar Direktur Kesehatan Keluarga	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Istilah	iv
BAB 1 Pendahuluan	1
BAB 2 Pelayanan Antenatal Terpadu	5
BAB 3 Keterpaduan Program dalam Layanan Antenatal	19
BAB 4 Pencatatan dan Pelaporan	45
BAB 4 Penutup	48
Lampiran	49
Daftar Pustaka	76

DAFTAR ISTILAH

ANC	: Ante Natal Care/ kunjungan kehamilan ke tenaga kesehatan
ePPGBM	: Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat
FANC Model	: <i>Focused Antenatal Care Model</i>
FKTP	: Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
FKTRL	: Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Lanjut
GPA	: Grande Partus Abortion
Hb	: Hemoglobin
HEEADSSS	: <i>Home, Education/Employment, Eating, Activities, Drugs, Sexuality, Safety and Suicide</i>
IMS	: Infeksi Menular Seksual
IUFD	: Intra Uterin Fetal Death
KEK	: Kekurangan Energi Kronis
LiLA	: Lingkar Lengan Atas
NAPZA	: Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya
PCOS	: <i>Polycystic Ovarium Syndrome</i>
PMT	: Pemberian Makanan Tambahan
PPIA	: Pencegahan Penularan Penyakit HIV dari Ibu ke Anak
PWSKIA	: Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RDT	: Rapid Diagnostic Test
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
SDKI	: Survey Demografi Kesehatan Indonesia
SUPAS	: Survey Penduduk Antar Sensus
SRS	: Sample Registration System
TFU	: Tinggi Fundus Uteri
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>

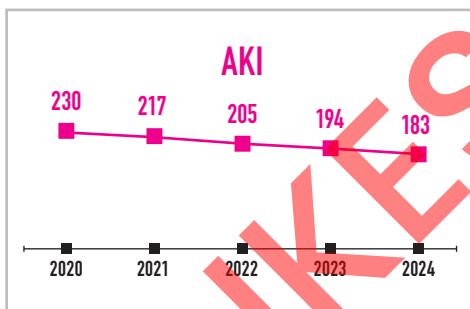
BAB 1 : PENDAHULUAN



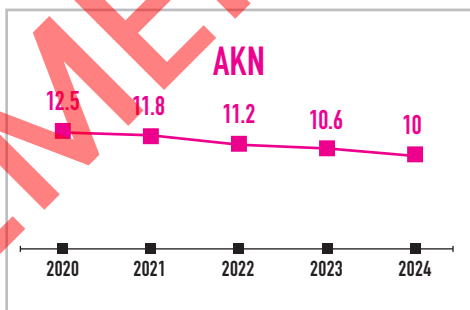
A. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa kondisi umum dan permasalahan kesehatan ibu dan anak di Indonesia antara lain: Angka Kematian Ibu (AKI) 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015) dan Angka Kematian Neonatal (AKN) 15 per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2017). Penurunan AKI dan AKN sudah terjadi namun angka penurunannya masih dibawah target RPJMN. Target RPJMN 2024 yaitu AKI 183 per 100.000 kelahiran hidup dan AKN 10 per 1000 kelahiran hidup. Berikut adalah target penurunan AKI dan penurunan AKN tahun 2020 - 2024:

GAMBAR 1.
TARGET PENURUNAN AKI TAHUN 2020 - 2024



GAMBAR 2.
TARGET PENURUNAN AKN TAHUN 2020 - 2024



Penyebab utama kematian ibu adalah hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan pasca persalinan (post partum). Sedangkan, penyebab kematian pada kelompok perinatal disebabkan oleh komplikasi intrapartum sebanyak 28,3% dan bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 19% (SRS, 2016). Ini menggambarkan bahwa kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan sangat menentukan persalinan dengan kondisi bayi yang dilahirkan.

Perdarahan pasca persalinan berkaitan dengan anemia saat remaja dan saat hamil. Berdasarkan Riskedas, terdapat peningkatan kasus yang cukup signifikan terkait anemia pada ibu hamil dari 37,1% pada tahun 2013 menjadi 48,9% pada tahun 2018. Ibu hamil dengan anemia berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Bila BBLR tidak ditangani dengan baik memiliki risiko kematian dan stunting.

Sementara itu, akses terhadap pelayanan kesehatan meningkat yang ditunjukkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan mengalami peningkatan dari 55,3 % (Riskedas, 2010) menjadi 79,3% (Riskedas, 2018) dan cakupan pemeriksaan kehamilan pertama (K1) 96,1%. Cakupan pemeriksaan kehamilan 4 kali (K4) naik dari 70,4% (Riskedas, 2013) menjadi 74,1% (Riskedas, 2018). Pelayanan Ante Natal Care (ANC) di Indonesia mengacu pada rekomendasi WHO tahun 2001 untuk melakukan minimal 4 kali kunjungan yang disebut sebagai *Focused Antenatal Care* (FANC) Model. Pelayanan antenatal termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tingkat Kabupaten/Kota di bidang kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 yang pencapaiannya diwajibkan 100%. tentang Administrasi Kependudukan. Diharapkan setiap ibu hamil sudah memiliki jaminan kesehatan sejak awal.

Beberapa hal yang perlu dipahami pada masa kehamilan seperti pelayanan ANC juga menjadi indikator penting dalam memastikan eliminasi penularan HIV, Sifilis dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017. Penyelenggaraan eliminasi tersebut dilakukan melalui kegiatan promosi kesehatan, surveilans kesehatan, deteksi dini, dan atau penanganan kasus. Deteksi dini dilakukan dengan rapid diagnostic test (RDT) pada ibu hamil paling sedikit satu kali pada masa kehamilan di pelayanan kesehatan yang memiliki standar diagnostik tersebut. Berdasarkan data rutin Direktorat Jenderal P2PML tahun 2019, dari 2.370.473 ibu hamil yang dites HIV 6.439 orang reaktif (0,27%). Sedangkan dari 2.576.979 ibu hamil diskrining Hepatitis B, diperoleh ibu hamil yang reaktif HbSag sejumlah 46.943 orang (1,82%).

Tuberkulosis (TB) pada ibu hamil berhubungan dengan peningkatan risiko abortus spontan, mortalitas perinatal dan berat badan lahir rendah. Pada 5-10% kasus TB pada wanita hamil dapat terjadi TB diseminata yang berisiko menularkan ke janin (TB kongenital).

Pada masa kehamilan dapat terjadi perubahan hormonal, perubahan bentuk tubuh/fisik, mual, muntah, ingin "sesuatu"), mengalami masalah kesehatan fisik (penyakit tidak menular dan penyakit menular) dan masalah jiwa (emosi tidak stabil seperti mudah tersinggung, marah, sedih, cemas, perilaku agresif dan sebagainya).

Masalah kesehatan jiwa pada ibu hamil juga perlu menjadi perhatian, berdasarkan hasil penelitian Kings College London tahun 2014-2016, memeriksa kesehatan jiwa 545 ibu hamil dengan hasil yang diperoleh bahwa satu dari empat ibu hamil (25%) mengalami masalah kesehatan jiwa selama kehamilan. Penelitian yang dilakukan Profesor Howard ini dipublikasikan di British Jurnal Psychiatry bertujuan untuk mewujudkan kesadaran dan membuktikan bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa ibu hamil penting dilaksanakan.

Integrasi pelayanan ANC juga melibatkan lintas program seperti Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Tuberkulosis, Malaria, IMS dan

Kecacingan), Penyakit Tidak Menular (DM, Hipertensi, Jiwa dan Jantung), Gizi serta beberapa program lokal dan spesifik lainnya. Pelayanan ANC juga mewajibkan penggunaan nomor e-KTP atau NIK menjadi nomor identitas tunggal seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Diharapkan setiap ibu hamil sudah memiliki jaminan kesehatan sejak awal.

Pelayanan ANC mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap untuk hamil, melahirkan dan menjaga agar lingkungan sekitar mampu melindungi bayi dari infeksi. Dokter dan bidan mampu melaksanakan ANC yang berkualitas serta melakukan deteksi dini (skrining), menegakkan diagnosis, melakukan tatalaksana dan rujukan sehingga dapat berkontribusi dalam upaya penurunan kematian maternal dan neonatal.

Pada tahun 2016 WHO mengeluarkan rekomendasi pelayanan antenatal yang bertujuan untuk memberikan pengalaman hamil dan melahirkan yang positif (*positive pregnancy experience*) bagi para ibu serta menurunkan angka mortalitas dan morbiditas ibu dan anak yang disebut sebagai *2016 WHO ANC Model*. Inti dari *2016 WHO ANC Model* ini adalah pemberian layanan klinis, pemberian informasi yang relevan dan tepat waktu serta memberi dukungan emosional. Semua ini diberikan oleh petugas kesehatan yang kompeten secara klinis dan memiliki keterampilan interpersonal yang baik kepada ibu hamil selama proses kehamilan. Salah satu rekomendasi dari WHO adalah pada ibu hamil normal ANC minimal dilakukan 8x, setelah dilakukan adaptasi dengan profesi dan program terkait, disepakati di Indonesia, ANC dilakukan minimal 6 kali dengan minimal kontak dengan dokter 2 kali untuk skrining faktor risiko/komplikasi kehamilan di trimester 1 dan skrining faktor risiko persalinan 1x di trimester 3.

Berdasarkan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk menerbitkan buku pedoman pelayanan antenatal terpadu yang disesuaikan dengan rekomendasi WHO, *2016 WHO ANC Model*. Buku ini merupakan revisi dari buku pedoman pelayanan antenatal terpadu edisi kedua tahun 2015.

B. TUJUAN PENULISAN PEDOMAN:

Menyediakan pedoman bagi seluruh petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan antenatal terpadu bagi seluruh ibu hamil di Indonesia.

C. PENGGUNA BUKU PEDOMAN

1. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan keluarga berencana.
2. Fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang menyediakan pelayanan antenatal baik FKTP maupun FKTRL.
3. Lintas program terkait di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
4. Institusi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan (Perguruan Tinggi, Politeknik Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Akademi Kebidanan, Bapelkes, pusat pelatihan dan lainnya).
5. Organisasi profesi terkait.

BAB 2: PELAYANAN ANTENATAL TERPADU



A. DEFINISI PELAYANAN ANTENATAL TERPADU

Pelayanan antenatal setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum mulainya proses persalinan yang komprehensif dan berkualitas dan diberikan kepada seluruh ibu hamil.

B. TUJUAN PELAYANAN ANTENATAL TERPADU

1. Tujuan umum:

Semua ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal yang komprehensif dan berkualitas **sehingga ibu hamil dapat menjalani kehamilan dan persalinan dengan pengalaman yang bersifat positif serta melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas.**

Pengalaman yang bersifat positif adalah pengalaman yang menyenangkan dan memberikan nilai tambah yang bermanfaat bagi ibu hamil dalam menjalankan perannya sebagai perempuan, istri dan ibu.

2. Tujuan khusus:

1. Terlaksananya pelayanan antenatal terpadu, termasuk konseling, dan gizi ibu hamil, konseling KB dan pemberian ASI.
2. Terlaksananya dukungan emosi dan psikososial sesuai dengan keadaan ibu hamil pada setiap kontak dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis/kebidanan dan interpersonal yang baik.
3. Setiap ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan antenatal terpadu minimal 6 kali selama masa kehamilan.
4. Terlaksananya pemantauan tumbuh kembang janin.
5. Deteksi secara dini kelainan/penyakit/gangguan yang diderita ibu hamil.
6. Dilaksanakannya tatalaksana terhadap kelainan/penyakit/gangguan pada ibu hamil sedini mungkin atau rujukan kasus ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan sistem rujukan yang ada.

C. SASARAN PELAYANAN ANTENATAL TERPADU

Seluruh wanita hamil di wilayah Republik Indonesia.

D. INDIKATOR

1. Kunjungan pertama (K1)

K1 adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis/kebidanan dan interpersonal yang baik, untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak pertama harus dilakukan sedini mungkin pada trimester pertama, sebaiknya sebelum minggu ke 8. Kontak pertama dapat dibagi menjadi K1 murni dan K1 akses.

K1 murni adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan pada kurun waktu trimester 1 kehamilan. Sedangkan K1 akses adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan pada usia kehamilan berapapun. Ibu hamil seharusnya melakukan K1 murni, sehingga apabila terdapat komplikasi atau faktor risiko dapat ditemukan dan ditangani sedini mungkin.

2. Kunjungan ke-4 (K4)

K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis/kebidanan untuk mendapatkan pelayanan antenatal terpadu dan komprehensif sesuai standar selama kehamilannya minimal 4 kali dengan distribusi waktu: 1 kali pada trimester pertama (0-12 minggu), 1 kali pada trimester kedua (>12minggu -24 minggu), dan 2 kali pada trimester ketiga (>24 minggu sampai dengan kelahiran). Kunjungan antenatal bisa lebih dari 4 kali sesuai kebutuhan (jika ada keluhan, penyakit atau gangguan kehamilan).

3. Kunjungan ke-6 (K6)

K6 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis/kebidanan untuk mendapatkan pelayanan antenatal terpadu dan komprehensif sesuai standar selama kehamilannya minimal 6 kali selama kehamilannya dengan distribusi waktu: 2 kali pada trimester kesatu (0-12 minggu), 1 kali pada trimester kedua (>12minggu - 24 minggu), dan 3 kali pada trimester ketiga (>24 minggu sampai dengan kelahiran), dimana minimal 2 kali ibu hamil harus kontak dengan dokter (1 kali di trimester 1 dan 1 kali di trimester 3). Kunjungan antenatal bisa lebih dari 6 (enam) kali sesuai kebutuhan dan jika ada keluhan, penyakit atau gangguan kehamilan. Jika kehamilan sudah mencapai 40 minggu, maka harus dirujuk untuk diputuskan terminasi kehamilannya.

Pemeriksaan dokter pada ibu hamil dilakukan saat :

- Kunjungan 1 di trimester 1 (satu) dengan usia kehamilan kurang dari 12 minggu atau dari kontak pertama
Dokter melakukan skrining kemungkinan adanya faktor risiko kehamilan atau penyakit penyerta pada ibu hamil termasuk didalamnya pemeriksaan *Ultrasonografi* (USG). Apabila saat K1 ibu hamil datang ke bidan, maka bidan tetap melakukan ANC sesuai standar, kemudian merujuk ke dokter.
- Kunjungan 5 di trimester 3
Dokter melakukan perencanaan persalinan, skrining faktor risiko persalinan termasuk pemeriksaan *Ultrasonografi* (USG) dan rujukan terencana bila diperlukan.

E. KONSEP PELAYANAN ANTENATAL TERPADU

Dalam pelayanan antenatal terpadu, tenaga kesehatan harus mampu melakukan deteksi dini masalah gizi, faktor risiko, komplikasi kebidanan, gangguan jiwa, penyakit menular dan tidak menular yang dialami ibu hamil serta melakukan tata laksana secara adekuat sehingga ibu hamil siap untuk menjalani persalinan bersih dan aman. Kerangka Konsep Pelayanan Antenatal Terpadu dapat dilihat pada gambar 1.

GAMBAR 3. KERANGKA KONSEP PELAYANAN ANTENATAL TERPADU



Masalah yang mungkin dialami ibu hamil antara lain:

1. Masalah gizi: anemia, KEK, obesitas, kenaikan berat badan tidak sesuai standar
Faktor risiko: usia ibu ≤ 16 tahun, usia ibu ≥ 35 tahun, anak terkecil ≤ 2 tahun,
2. hamil pertama ≥ 4 tahun, interval kehamilan > 10 tahun, persalinan ≥ 4 kali, gemeli/kehamilan ganda, kelainan letak dan posisi janin, kelainan besar janin, riwayat obstetrik jelek (keguguran/gagal kehamilan), komplikasi pada persalinan yang lalu (riwayat vakum/forsep, perdarahan pasca persalinan dan atau transfusi), riwayat bedah sesar, hipertensi, kehamilan lebih dari 40 minggu.
3. Komplikasi kebidanan: ketuban pecah dini, perdarahan pervaginam, hipertensi dalam kehamilan/pre eklampsia/eklampsia, ancaman persalinan prematur, distosia, plasenta previa, dll.

4. Penyakit tidak menular: hipertensi, diabetes mellitus, kelainan jantung, ginjal, asma, kanker, epilepsi, dll.
5. Penyakit menular: HIV, sifilis, hepatitis B, tetanus maternal, malaria, TB, demam berdarah, tifus abdominalis, dll.
6. Masalah kesehatan jiwa: depresi, gangguan kecemasan, psikosis, skizofrenia.

Pelayanan antenatal terpadu adalah diberikan kepada semua ibu hamil dengan cara:

1. Menyediakan kesempatan pengalaman positif bagi setiap ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan antenatal terpadu.
2. Melakukan pemeriksaan antenatal pada setiap kontak.
3. Memberikan konseling kesehatan dan gizi ibu hamil, termasuk konseling KB dan pemberian ASI.
4. Memberikan dukungan emosi dan psikososial sesuai dengan kebutuhan/keadaan ibu hamil serta membantu ibu hamil agar tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman selama masa kehamilan dan menyusui.
5. Melakukan pemantauan tumbuh kembang janin.
6. Mendeteksi secara dini kelainan/penyakit/gangguan yang diderita ibu hamil.
7. Melakukan tatalaksana terhadap kelainan/penyakit/gangguan pada ibu hamil sedini mungkin atau melakukan rujukan kasus ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan sistem rujukan.
8. Mempersiapkan persalinan yang bersih dan aman.
9. Melakukan rencana antisipasi dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi penyulit/komplikasi pada proses persalinan.
10. Melakukan tatalaksana kasus serta rujukan tepat waktu pada kasus kegawatdaruratan maternal neonatal.
11. Melibatkan ibu hamil, suami dan keluarga dalam menjaga kesehatan dan gizi ibu hamil, mempersiapkan persalinan dan kesiagaan apabila terjadi komplikasi.

Standar pelayanan antenatal terpadu minimal adalah sebagai berikut (10T):

1. **Timbang** berat badan dan ukur tinggi badan
2. Ukur **tekanan darah**
3. Nilai **status gizi** (ukur lingkar lengan atas/LILA)
4. Ukur **tinggi puncak rahim** (fundus uteri)
5. **Tentukan** presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ)
6. **Skrining** status imunisasi **tetanus** dan berikan imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan
7. Pemberian **tablet tambah darah** minimal 90 tablet selama masa kehamilan

8. **Tes laboratorium:** tes kehamilan, kadar hemoglobin darah, golongan darah, tes triple eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis B) dan malaria pada daerah endemis. Tes lainnya dapat dilakukan sesuai indikasi seperti: glukoprotein urin, gula darah sewaktu, sputum Basil Tahan Asam (BTA), kusta, malaria daerah non endemis, pemeriksaan feses untuk kecacingan, pemeriksaan darah lengkap untuk deteksi dini thalasemia dan pemeriksaan lainnya.

9. **Tata laksana/penanganan** kasus sesuai kewenangan

10. **Temu wicara** (konseling)

Informasi yang disampaikan saat konseling minimal meliputi hasil pemeriksaan, perawatan sesuai usia kehamilan dan usia ibu, gizi ibu hamil, kesiapan mental, mengenali tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas, persiapan persalinan, kontrasepsi pascapersalinan, perawatan bayi baru lahir, inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif.

Keterangan:

- Tes laboratorium yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal adalah: pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan Hb dan pemeriksaan glukoproteinuri (atas indikasi).
- Pada fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memiliki vaksin tetanus difteri dan/atau pemeriksaan laboratorium, fasilitas pelayanan kesehatan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas untuk penyediaan dan/atau pemeriksaan, atau merujuk ibu hamil ke Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang dapat melakukan pemeriksaan tersebut.

F. LANGKAH TEKNIS PELAYANAN ANTENATAL TERPADU

1. **Menyediakan kesempatan pengalaman positif bagi setiap ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan antenatal terpadu pada saat dibutuhkan.**

Pelayanan antenatal terpadu diberikan pada saat petugas kesehatan kontak dengan ibu hamil. Kontak dalam hal ini didefinisikan sebagai saat petugas kesehatan ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan maupun saat di dalam sebuah komunitas/lingkungan. Kontak sebaiknya dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sehingga ibu hamil mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan komprehensif.

2. Layanan ANC oleh dokter umum

Ibu hamil minimal 2x diperiksa oleh dokter, 1x pada trimester 1 dan 1x pada trimester 3 (kunjungan antenatal ke 5).

• Kunjungan pada trimester 1

Pemeriksaan dokter pada kontak pertama ibu hamil di trimester 1 bertujuan untuk skrining adanya faktor risiko atau komplikasi. Apabila kondisi ibu hamil normal, kunjungan antenatal dapat dilanjutkan oleh bidan. Namun bilamana ada faktor risiko atau komplikasi maka pemeriksaan kehamilan selanjutnya harus ke dokter atau dokter spesialis sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter tetap mengikuti pola anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan tindak lanjut:

a. Anamnesis dan Evaluasi Kesehatan Ibu Hamil

- Anamnesis: kondisi umum, data dasar, HPHT, siklus haid, faktor risiko infeksi saluran reproduksi, dll
- Riwayat kesehatan ibu sekarang: hipertensi, jantung, asma, TB, tiroid, HIV, IMS, hepatitis B, alergi, asma, autoimun, diabetes, dll.
- Skrining status imunisasi tetanus
- Riwayat perilaku berisiko 1 bulan sebelum hamil: merokok, minum alkohol, minum obat-obatan, pola makan berisiko, aktifitas fisik, pemakaian kosmetik, dll.
- Riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya (termasuk keguguran, hamil kembar dan lahir mati).
- Riwayat penyakit keluarga: hipertensi, diabetes, sesak nafas, asma, jantung, TB, alergi, gangguan kejiwaan, kelainan darah, Hepatitis B, HIV, dll.

b. Pemeriksaan Fisik Umum

- Keadaan umum, kesadaran, konjungtiva, sklera, kulit, leher, gigi mulut,
- THT, jantung, paru, perut, ekstremitas.
- Berat badan dan tinggi badan.
- Tanda vital : tekanan darah, nadi, suhu tubuh, frekuensi nafas

c. Pemeriksaan Terkait Kehamilan

- Lingkar lengan atas
- Pemeriksaan dan penentuan Indek Masa Tubuh (IMT) sebelum hamil. Skrining preeklamsi (lihat BAB III. Keterpaduan program, sub bab penemuan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular pada Kehamilan)

d. Pemeriksaan Penunjang Pada Kehamilan

- Pemeriksaan laboratorium : tes kehamilan, kadar hemoglobin darah, golongan darah, malaria di daerah endemis, tes triple eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis B), dan tes lainnya sesuai indikasi
- Pemeriksaan USG
- Pemeriksaan EKG atas indikasi

Pada pemeriksaan pertama oleh dokter, maka dokter harus menyimpulkan status kehamilannya (GPA), kehamilan normal atau kehamilan berkomplikasi (sebutkan jenis komplikasinya). Selain itu dokter harus memberikan rekomendasi antara lain:

- ANC dapat dilakukan di FKTP, atau
- Konsul ke dokter spesialis, atau
- Rujuk ke FKRTL

Pada keadaan khusus misalnya wabah penyakit tertentu maka dilakukan skrining awal sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

• Kunjungan pada trimester 3

Pada kehamilan trimester 3, ibu hamil harus diperiksa dokter minimal sekali (kunjungan antenatal ke-5 dan usia kehamilan 32-36 minggu). Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi adanya faktor risiko pada persalinan dan perencanaan persalinan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter tetap mengikuti pola anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan tindak lanjut:

a. Anamnesis dan evaluasi kesehatan ibu hamil

- Kondisi umum, keluhan
- Riwayat kesehatan ibu sekarang, status imunisasi tetanus
- Perencanaan persalinan (tempat persalinan, transportasi, calon pendonor darah, pembiayaan, pendamping persalinan, dll),
- Pilihan rencana kontrasepsi, dll.

b. Pemeriksaan fisik umum

- Keadaan umum, kesadaran, konjungtiva, sklera, kulit, leher, gigi mulut, THT, jantung, paru, perut, ekstremitas.
- Berat badan dan tinggi badan.
- Tanda vital : tekanan darah, nadi, suhu tubuh, frekuensi nafas

c. Pemeriksaan terkait kehamilan: Leopold

- d. Pemeriksaan penunjang pada kehamilan:
- Pemeriksaan laboratorium: kadar hemoglobin darah, dan pemeriksaan penunjang lain sesuai indikasi
 - Pemeriksaan USG
- e. Rencana konsultasi lanjut (ke bagian gizi, kebidanan, anak, penyakit dalam, THT, neurologi, psikiatri, dll)
- f. Konseling
- Pada akhir pemeriksaan dokter harus bisa menyimpulkan:
- Status kehamilannya (GPA)
 - Tidak didapatkan penyulit pada kehamilan saat ini, atau
 - Didapatkan masalah kesehatan/komplikasi (sebutkan)
- Dokter juga harus memberikan rekomendasi:
- Dapat melahirkan di FKTP (PONED/non PONED)
 - Rujuk untuk melahirkan di FKRTL
- Konsultasi ke dokter spesialis untuk menentukan tempat persalinan

3. Layanan ANC oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi klinis/kebidanan selain dokter

Apabila saat kunjungan antenatal dengan dokter tidak ditemukan faktor risiko maupun komplikasi, kunjungan antenatal selanjutnya dapat dilakukan ke tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi klinis/kebidanan selain dokter. Kunjungan antenatal yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter adalah kunjungan ke-2 di trimester 1, kunjungan ke-3 di trimester 2 dan kunjungan ke-4 dan 6 di trimester 3. Tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan antenatal, konseling dan memberikan dukungan sosial pada saat kontak dengan ibu hamil.

Pemeriksaan antenatal dan konseling yang dilakukan adalah:

- a. Anamnesis: kondisi umum, keluhan saat ini.
- Kondisi umum, keluhan saat ini
 - Tanda-tanda penting yang terkait masalah kehamilan: mual/muntah, demam, sakit kepala, perdarahan, sesak nafas, keputihan, dll
 - Gerakan janin
 - Riwayat kekerasan terhadap perempuan (KtP) selama kehamilan

- Riwayat kekerasan terhadap perempuan (KtP) selama kehamilan
 - Perencanaan persalinan (tempat persalinan, transportasi, calon pendonor darah, pembiayaan, pendamping persalinan, dll)
 - Pemantauan konsumsi tablet tambah darah
 - Pola makan ibu hamil
 - Pilihan rencana kontrasepsi, dll
- b. Pemeriksaan fisik umum
- Pemantauan berat badan
 - Pemantauan tanda vital : tekanan darah, nadi, suhu tubuh, frekuensi nafas
 - Pemantauan LiLA pada ibu hamil KEK
- c. Pemeriksaan terkait kehamilan
- Pemeriksaan tinggi fundus uteri (TFU)
 - Pemeriksaan Leopold
 - Pemeriksaan denyut jantung janin
- d. Pemeriksaan penunjang: pemeriksaan hemoglobin darah pada ibu hamil anemi, pemeriksaan glukoproteinuri
- e. Pemberian imunisasi Td sesuai hasil skrining
- f. Suplementasi tablet Fe dan kalsium
- g. Komunikasi, informasi, edukasi dan konseling:
- Perilaku hidup bersih dan sehat
 - Tanda bahaya pada kehamilan, persalinan dan nifas
 - Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)
 - Peran suami dan keluarga dalam kehamilan dan perencanaan persalinan
 - Asupan gizi seimbang
 - KB paska persalinan
 - IMD dan pemberian ASI eksklusif
 - Peningkatan kesehatan intelegensia pada kehamilan (*Brain Booster*)
- Untuk meningkatkan intelegensia bayi yang akan dilahirkan, ibu hamil dianjurkan memberikan stimulasi auditori dan pemenuhan nutrisi pengungkitt otak (*brain booster*) secara bersamaan pada periode kehamilan

Tenaga kesehatan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi ibu hamil (menggunakan grafik evaluasi kehamilan dan grafik peningkatan berat badan, terlampir). Apabila hasil pemantauan dan evaluasi melewati garis batas grafik, ibu hamil harus dikonsultasikan ke dokter.

Indikasi merujuk ke dokter dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

A. Riwayat kehamilan dahulu

1. Riwayat perdarahan pada kehamilan/persalinan/nifas
2. Riwayat hipertensi pada kehamilan/nifas
3. Riwayat IUFD/stillbirth
4. Riwayat kehamilan kembar
5. Riwayat keguguran > 3x berturut-turut
6. Riwayat kehamilan sungsang/letak lintang/letak oblik
7. Riwayat kematian janin/perinatal
8. Riwayat persalinan dengan SC, dll

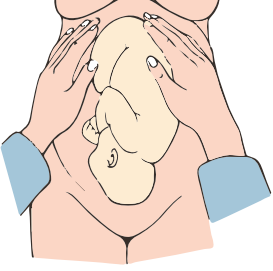
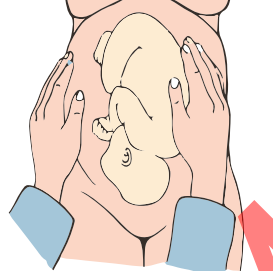
B. Riwayat medis

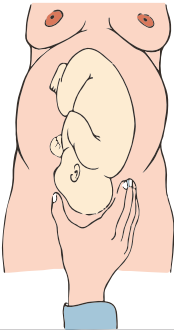
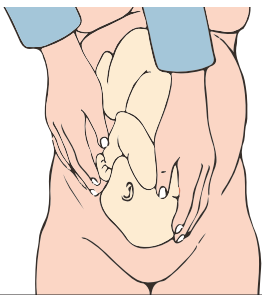
1. Riwayat penyakit tidak menular (jantung, hipertensi, diabetes mellitus, ginjal, alergi makanan/obat, autoimun, talasemia/gangguan hematologi lain, epilepsi, dll)
2. Riwayat penyakit menular (HIV, Sifilis/IMS lainnya, Hepatitis B, TB, malaria, tifoid, dll)
3. Riwayat masalah kejiwaan, dll

C. Riwayat kehamilan sekarang

1. Muntah berlebihan sampai tidak bisa makan dan minum
2. Perdarahan
3. Nyeri perut hebat
4. Pusing/sakit kepala berat
5. Demam lebih dari 2 hari
6. Keluar cairan berlebihan dan berbau dari vagina
7. Batuk lama lebih dari 2 minggu atau kontak erat/serumah dengan penderita tuberkulosis
8. Gerakan janin berkurang atau tidak terasa (mulai kehamilan 20 minggu)
9. Perubahan perilaku: gelisah, menarik diri, bicara sendiri, tidak mau mandi
10. Kekerasan fisik
11. Gigi dan mulut: gigi berlubang, gusi mudah berdarah, gusi bengkak, dll

TABEL 1. PALPASI ABDOMEN DAN TEKNIK LEOPOLD I-IV

Teknik	Waktu Pengukuran	Tujuan
Palpasi Abdomen	Awal trimester 1	• Meraba ada/tidak massa intra abdomen • Menentukan tinggi fundus uteri
Leopold I 	Akhir Trimester 1	Menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin yang terletak di fundus uteri
Leopold II 	Trimester 2 dan 3	Menentukan bagian janin pada sisi kiri dan kanan ibu

Leopold III 	Trimester 2 dan 3	Menentukan bagian janin yang terletak di bagian bawah uterus
Leopold IV 	Trimester 3 Usia gestasi >36 minggu	Menentukan berapa jauh masuknya janin ke pintu atas panggul



BAB 3:

KETERPADUAN PROGRAM

DALAM LAYANAN ANTENATAL



A. GIZI

Asupan zat gizi untuk bayi di dalam kandungan berasal dari persediaan zat gizi di dalam tubuh ibunya. Oleh karena itu sangat penting bagi calon ibu hamil untuk mempunyai status gizi yang baik sebelum memasuki kehamilannya, misalnya tidak kurus dan tidak anemia, untuk memastikan cadangan zat gizi ibu hamil mencukupi untuk kebutuhan janinnya. Saat hamil, salah satu indikator apakah janin mendapatkan asupan makanan yang cukup adalah melalui pemantauan adekuat tidaknya pertambahan berat badan (BB) ibu selama kehamilannya (PBBH). Bila PBBH tidak adekuat, janin berisiko tidak mendapatkan asupan yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya didalam kandungan. Ibu yang saat memasuki kehamilannya kurus dan ditambah dengan PBBH yang tidak adekuat, berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah.

PBBH yang optimal berbeda-beda sesuai dengan status gizi Ibu yang diukur dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) sebelum hamil atau pada saat memasuki trimester pertama seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini. Semakin kurus seorang Ibu, semakin besar target PBBH-nya untuk menjamin ketercukupan kebutuhan gizi janin.

Tabel 2. Peningkatan Berat Badan Selama Kehamilan yang Direkomendasikan sesuai IMT

IMT pra hamil (kg/m ²)	Kenaikan BB total selama kehamilan (kg)	Laju kenaikan BB pada trimester III (rentang rerata kg/minggu)
Gizi Kurang / KEK (<18.5)	12.71 — 18.16	0.45 (0.45 — 0.59)
Normal (18.5 - 24.9)	11.35 — 15.89	0.45 (0.36 — 0.45)
Kelebihan BB (25.0-29.9)	6.81 — 11.35	0.27 (0.23 — 0.32)
Obes (≥30.0)	4.99 — 9.08	0.23 (0.18 — 0.27)

Adapun cara menghitung IMT adalah dengan membagi besaran Berat Badan (BB) dalam kilogram (kg) dengan Tinggi Badan (TB) dalam meter (m) kuadrat sesuai formula berikut:

$$\text{IMT} = \frac{\text{Berat Badan (kg)}}{\text{Tinggi Badan (m)} \times \text{Tinggi Badan (m)}}$$

1. Gizi Seimbang pada Ibu Hamil

Gizi seimbang pada ibu hamil sangat perlu diperhatikan karena ibu hamil harus memenuhi kebutuhan gizi untuk dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan janinnya. Ibu hamil harus mengonsumsi beraneka ragam makanan dengan jumlah dan proporsi yang seimbang. Pesan gizi seimbang yang khusus untuk ibu hamil, antara lain:

a. Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan yang lebih banyak

Ibu hamil perlu mengonsumsi aneka ragam makanan yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan energi, protein dan zat gizi mikro (vitamin dan mineral). Kebutuhan zat gizi yang meningkat selama kehamilan, antara lain:

- **Protein**

Untuk pertumbuhan janin dan untuk mempertahankan kesehatan ibu. Ibu hamil sangat dianjurkan untuk mengonsumsi makanan sumber protein hewani seperti ikan, susu dan telur.

- **Zat Besi**

Zat besi merupakan unsur penting dalam pembentukan hemoglobin pada sel darah merah. Kekurangan hemoglobin disebut anemia atau dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayi seperti BBLR, perdarahan dan peningkatan risiko kematian. Makanan sumber zat besi yang sangat baik dikonsumsi ibu hamil yaitu ikan, daging, hati dan tempe. Ibu hamil juga perlu mengonsumsi satu Tablet Tambah Darah (TTD) per hari selama kehamilan dan dilanjutkan selama masa nifas.

- **Asam Folat**

Untuk pembentukan sel dan sistem saraf termasuk sel darah merah. Sayuran hijau seperti bayam dan kacang-kacangan banyak mengandung asam folat yang sangat diperlukan pada masa kehamilan.

- **Vitamin**

Buah berwarna merupakan sumber vitamin yang baik bagi tubuh dan buah yang berserat karena dapat melancarkan buang air besar sehingga mengurangi risiko sembelit pada ibu hamil.

- **Kalsium**

Untuk mengganti cadangan kalsium ibu yang digunakan untuk pembentukan jaringan baru pada janin. Apabila konsumsi kalsium tidak mencukupi maka akan berakibat meningkatkan risiko ibu mengalami komplikasi yang disebut keracunan kehamilan (pre eklampsia). Selain itu ibu akan mengalami pengeroposan tulang dan gigi. Sumber kalsium yang baik adalah sayuran hijau, kacang-kacangan dan ikan teri serta susu.

- **Iodium**

Iodium merupakan bagian hormon tiroksin (T4) dan triiodotironin (T3) yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan bayi. Sumber iodium yang baik adalah makanan laut seperti ikan, udang, kerang, rumput laut. Setiap memasak diharuskan menggunakan garam beriodium. Untuk mengatasi “Hiperemesis Gravidarum” (rasa mual dan muntah berlebihan), ibu hamil dianjurkan untuk makan dalam porsi kecil tetapi sering, makan secara tidak berlebihan dan hindari makanan berlemak serta makanan berbumbu tajam (merangsang).

b. Batasi mengonsumsi makanan yang mengandung garam tinggi

Pembatasan konsumsi garam dapat mencegah hipertensi selama kehamilan. Hipertensi selama kehamilan akan meningkatkan risiko kematian janin, terlepasnya plasenta, serta gangguan pertumbuhan.

c. Minum air putih yang lebih banyak

Air merupakan sumber cairan yang paling baik dan berfungsi untuk membantu pencernaan, mengatur keseimbangan asam basa tubuh, dan mengatur suhu tubuh. Kebutuhan air selama kehamilan meningkat agar dapat mendukung sirkulasi janin, produksi cairan amnion dan meningkatnya volume darah. Ibu hamil memerlukan asupan air minum sekitar 2-3 liter perhari (8-12 gelas sehari).

d. Batasi Konsumsi Kafein

Kafein bila dikonsumsi oleh ibu hamil akan mempunyai efek diuretik dan stimulan. Oleh karenanya bila ibu hamil minum kopi sebagai sumber utama kafein yang tidak terkontrol, akan mengalami peningkatan buang air kecil (BAK) yang akan berakibat dehidrasi, tekanan darah meningkat dan detak jantung juga akan meningkat.

Pangan sumber kafein lainnya adalah coklat, teh dan minuman suplemen energi. Satu botol minuman suplemen energi mengandung kafein setara dengan 1-2 cangkir kopi. Disamping mengandung kafein, kopi juga mengandung inhibitor (zat yang mengganggu penyerapan zat besi). Konsumsi kafein pada ibu hamil juga akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan janin, karena metabolisme janin belum sempurna.

Walaupun the National Institute of Health USA (1993) merekomendasikan konsumsi kafein bagi ibu hamil yang aman adalah 150-250 mg/hari atau 2 (dua) cangkir kopi/hari, namun dianjurkan kepada ibu hamil “selama kehamilan ibu harus bijak dalam mengonsumsi kafein”, batasi dalam batas aman yaitu paling banyak 2 cangkir kopi/hari atau hindari sama sekali karena dalam kopi tidak ada kandungan zat gizi.

2. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada Ibu Hamil

Ibu hamil rentan menderita anemia karena adanya peningkatan volume darah selama kehamilan untuk pembentukan plasenta, janin dan cadangan zat besi dalam ASI. Kadar Hb pada ibu hamil menurun pada trimester I dan terendah pada trimester II, selanjutnya meningkat kembali pada trimester III. Penurunan kadar Hb pada ibu hamil yang menderita anemia sedang dan berat akan mengakibatkan peningkatan risiko persalinan, peningkatan kematian anak dan infeksi penyakit. Upaya pencegahan anemia gizi besi pada ibu hamil dilakukan dengan memberikan 1 tablet setiap hari selama kehamilan minimal 90 tablet, dimulai sedini mungkin dan dilanjutkan sampai masa nifas.

Tabel 3. Rekomendasi WHO tentang Pengelompokan Anemia (g/dL) Berdasarkan Umur

Populasi	Tidak Anemia	Anemia		
		Ringan	Sedang	Berat
Anak 6-59 bulan	11	10,0 – 10,9	7,0 – 9,9	< 7,0
Anak 5-11 tahun	11,5	11,0 – 11,4	8,0 – 10,9	< 8,0
Anak 12-14 tahun	12	11,0 – 11,9	8,0 – 10,9	< 8,0
WUS tidak hamil	12	11,0 – 11,9	8,0 – 10,9	< 8,0
Ibu hamil	11	10,0 – 10,9	7,0 – 9,9	< 7,0
Laki-laki ≥ 15 tahun	13	11,0 – 12,9	8,0 – 10,9	< 8,0

Sumber: WHO, 2012

Catatan:

- Di daerah endemis malaria, selain upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengobati malaria, juga harus tetap disediakan TTD. Pemberian TTD pada ibu hamil yang pernah menderita malaria perlu dimonitor secara periodik.
- Ibu hamil yang menderita kecacingan tetap diberi TTD disamping pemberian obat cacing. Biasanya ibu hamil dengan kecacingan akan menderita anemia sedang, maka pemberian TTD dapat mencegah terjadinya anemia menjadi lebih berat.

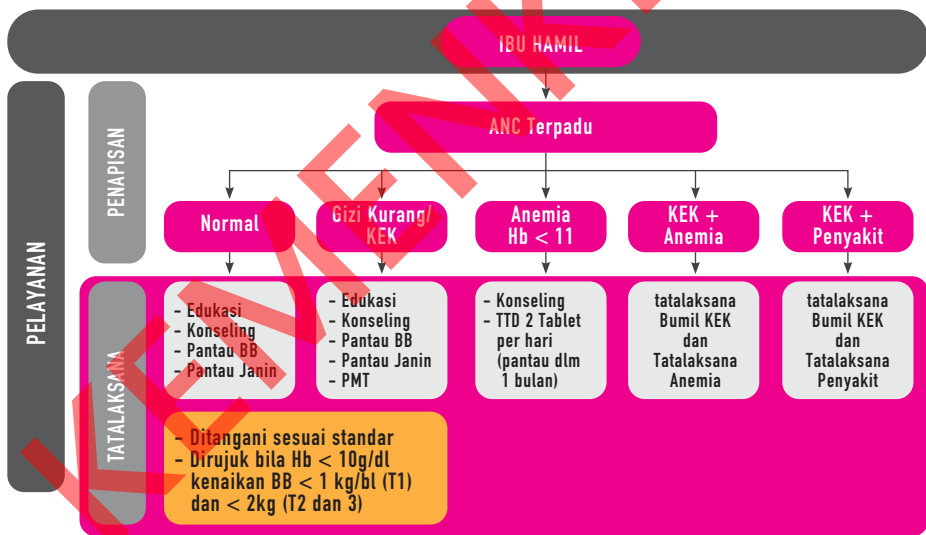
3. Pemberian Kalsium pada Ibu Hamil

Pada daerah dengan intake kalsium yang rendah direkomendasikan pemberian suplementasi tablet kalsium pada ibu hamil sebesar 1.500 -2.000 mg secara oral dibagi dalam 3x pemberian per hari. Interaksi dapat terjadi antara suplemen besi dan kalsium. Oleh karena harus ada jarak pemberian selama beberapa jam. Pemberian tablet kalsium untuk mengurangi risiko preeklamsi.

4. Penanggulangan Kekurangan Energi Kronik pada Ibu Hamil

Penanggulangan ibu hamil KEK seharusnya dimulai sejak sebelum hamil bahkan sejak usia remaja putri. Upaya penanggulangan tersebut membutuhkan koordinasi lintas program dan perlu dukungan lintas sektor, organisasi profesi, tokoh masyarakat, LSM dan institusi lainnya.

Bagan 1. Alur Pelayanan Gizi Pada Ibu Hamil



Penyediaan makan pada ibu hamil KEK diawali dengan perhitungan kebutuhan, pemberian diet (termasuk komposisi zat gizi, bentuk makanan, dan frekuensi pemberian dalam sehari). Ibu hamil KEK perlu penambahan energi sebesar 500 kkal yang dapat berupa pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal, PMT pabrikasi atau minuman padat gizi.

B. HIV, SIFILIS/IMS LAIN DAN HEPATITIS B

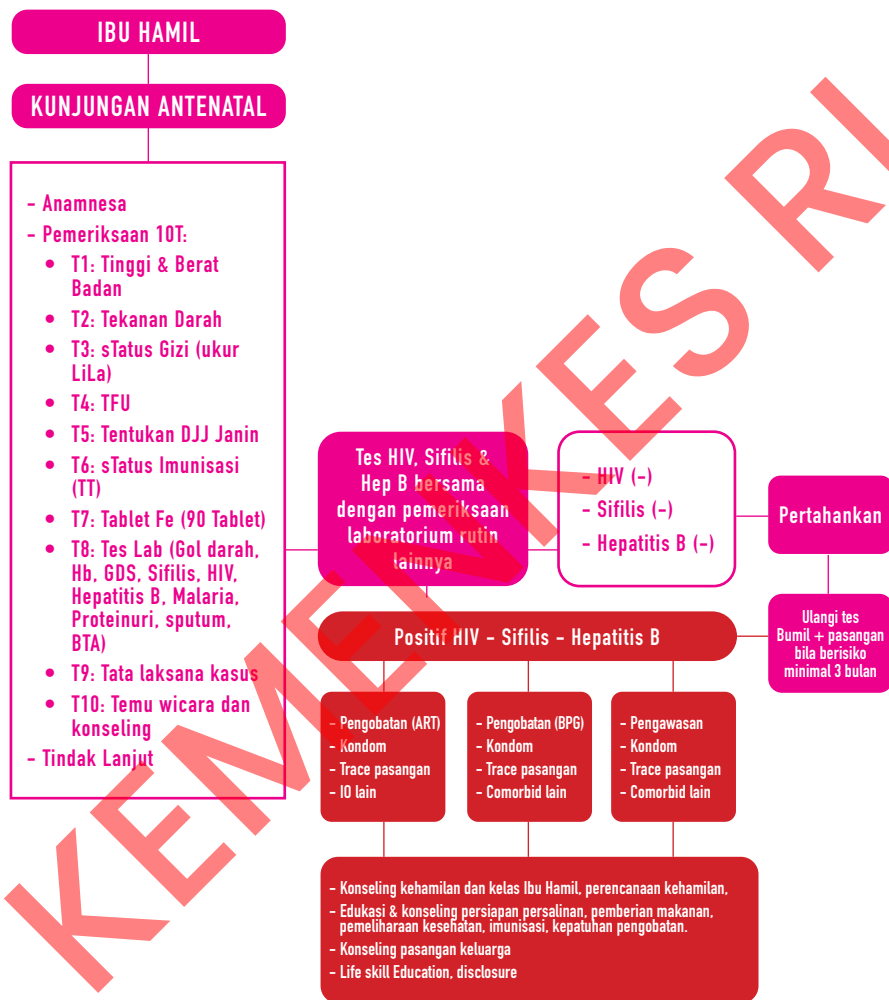
Penularan vertikal HIV, Sifilis, Hepatitis B dan IMS lainnya dapat terjadi dari ibu ke bayi yang dikandungnya selama dalam kandungan, persalinan dan menyusui. Upaya kesehatan masyarakat untuk mencegah penularan ini dimulai dengan skrining pada ibu hamil terhadap HIV, Sifilis dan Hepatitis B pada saat pemeriksaan antenatal pertama pada trimester pertama. Tes skrining menggunakan tes cepat (rapid tes) HIV, tes cepat sifilis (TP rapid) dan tes cepat HBsAg. Tes cepat ini relatif murah, sederhana dan tanpa memerlukan keahlian khusus sehingga dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan (pemberi layanan langsung/bidan). Skrining HIV, sifilis dan hepatitis B pada ibu hamil dilaksanakan secara bersamaan dalam paket pelayanan antenatal terpadu. Secara program nasional upaya pengendalian terhadap ketiga penyakit infeksi menular langsung ini disebut Program Pencegahan Penularan HIV, Sifilis dan hepatitis B dari Ibu ke Anak (PPIA) dengan tujuan eliminasi penularan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan HIV Sifilis dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak.

Kebijakan dalam pelaksanaan PPIA diintegrasikan dalam layanan KIA sebagai berikut:

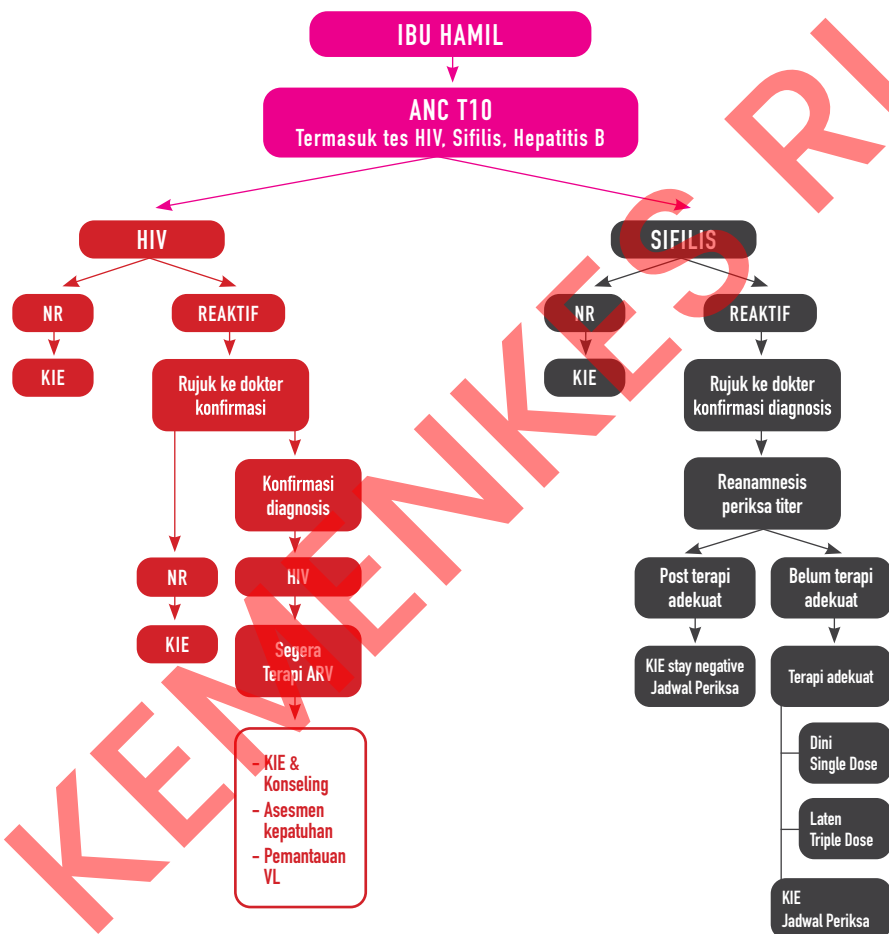
- a. PPIA merupakan bagian dari program nasional pengendalian HIV, IMS, Hepatitis B dan program kesehatan ibu dan anak.
- b. Pelaksanaan kegiatan PPIA diintegrasikan pada layanan KIA, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan remaja di setiap jenjang pelayanan kesehatan dengan ekspansi secara bertahap dan melibatkan peran non pemerintah, LSM dan komunitas.
- c. Setiap perempuan yang datang ke layanan KIA-KB dan remaja mendapat layanan kesehatan diberi informasi tentang PPIA.
- d. Di setiap jenjang pelayanan KIA, tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan tes HIV, Sifilis dan hepatitis B kepada semua ibu hamil minimal 1 kali sebagai bagian dari pemeriksaan laboratorium rutin pada waktu pemeriksaan antenatal pada kunjungan 1 (K1) hingga menjelang persalinan. Pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan pada kunjungan pertama trimester 1.

- e. Setiap kabupaten kota wajib melakukan orientasi bagi tenaga kesehatan klinis/kebidanan agar FKTP dan FKRTL mampu melakukan skrining tes HIV, Sifilis dan Hepatitis B, karena skrining HIV merupakan SPM kesehatan kabupaten kota dan pelaksanaan tesnya sama mudahnya antara HIV, Sifilis & Hepatitis B yaitu menggunakan rapid tes (tes cepat). Dalam hal FKTP dan jaringannya belum mampu maka:
 - i. Merujuk ibu hamil ke fasilitas pelayanan yang memadai;
 - ii. Melakukan *on the job training* bagi tenaga kesehatan (pemberi pelayanan kesehatan langsung);
 - iii. Pelimpahan wewenang kepada tenaga kesehatan lain yang terlatih dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan setempat.
- f. Setiap ibu hamil yang positif HIV, atau Sifilis atau Hepatitis B wajib diberikan tatalaksana sesuai standar meliputi pemberian terapi, pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, konseling menyusui dan konseling KB.
- g. Perencanaan ketersediaan logistik (obat dan reagen) dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota sampai Provinsi dan berkoordinasi dengan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan.
- h. Pencatatan valid berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK), NKK dan domisili (PP 40/2019 ps1 30, Permenkes 31/2019).
- i. Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan teknis serta umpan balik PPIA sebagai upaya kesehatan masyarakat.

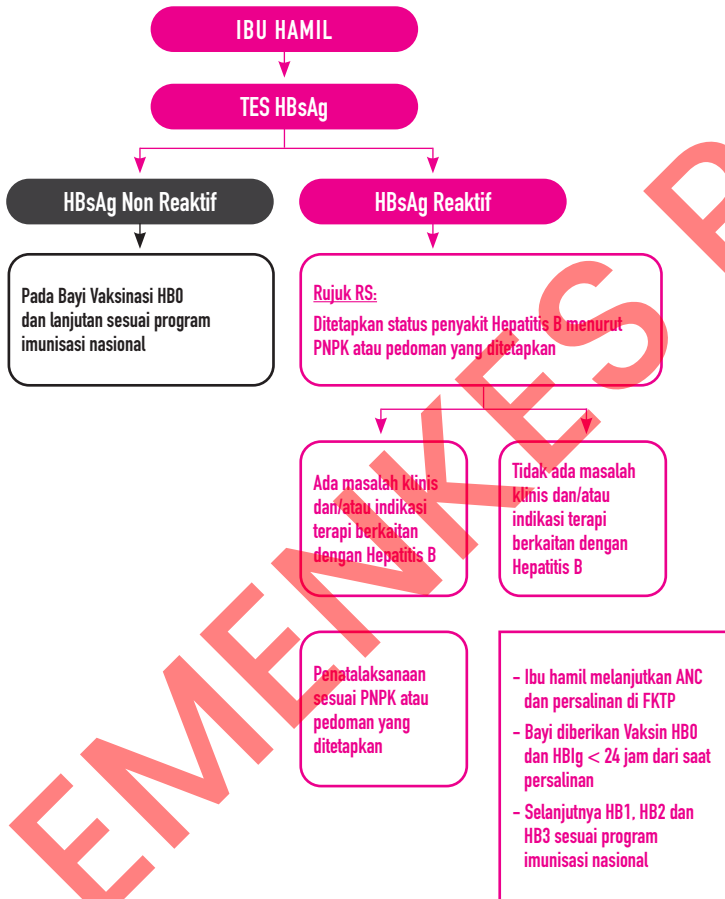
Bagan 2. Alur Pemeriksaan Umum PPIA (HIV, Sifilis dan Hepatitis B)



Bagan 3. Alur Pencegahan Penularan HIV dan Sifilis Selama Kehamilan



Bagan 4. Alur Pencegahan dan Rujukan Hepatitis B Selama Kehamilan



Pengobatan ibu hamil dengan Hepatitis B yang dirujuk dan ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam atau konsultan gastro enterologi dan hepatologi di Rumah Sakit Rujukan. Sebelum dirujuk, ibu hamil harus mendapatkan informasi yang lengkap tentang penyakit Hepatitis B, cara pencegahan, cara penularan serta pengobatan yang sesuai.

C. MALARIA

Strategi pelayanan terpadu pengendalian malaria dalam antenatal adalah pemeriksaan (skrining) malaria pada kunjungan pertama antenatal dan pemberian kelambu berinsektisida terhadap semua ibu hamil yang tinggal di kabupaten/kota endemis tinggi malaria. Sedangkan untuk ibu hamil yang tinggal di kabupaten/kota endemis rendah dilakukan selektif pada ibu hamil yang memiliki gejala dan:

- a) tinggal di desa endemis tinggi malaria (desa merah),
- b) ada riwayat berkunjung/tinggal di daerah endemis malaria 1 (satu) bulan terakhir,
- c) pernah sakit malaria dalam 2 tahun terakhir.

Bagan 5. Alur Kebijakan Terpadu Malaria Dalam Layanan Antenatal

PROGRAM MALARIA DENGAN PELAYANAN IBU HAMIL

Untuk daerah endemis TINGGI (Merah) malaria pada kunjungan pertama ANC semua ibu hamil dilakukan:

1.

PEMBERIAN KELAMBU
BERINSEKTISIDA

2.

SKRINING DARAH MALARIA
(RDT/MIKROSKOPIS)

3.

PEMBERIAN TERAPI
PADA IBU HAMIL
POSITIF MALARIA



* Wilayah endemis tinggi malaria semua ibu hamil skrining malaria, di wilayah endemis rendah dilakukan secara selektif

** jika malaria berat beri pra rujukan dengan artesunat i.m (dosis 2.4mg/kgBB)

ACT yaitu Dihydroartemisinin + Piperaquin (DHP) 3-3-3

D. TUBERKULOSIS

Manifestasi klinis TB pada kehamilan umumnya sama dengan wanita yang tidak hamil yaitu manifestasi umum dari TB paru. Semua wanita hamil harus diskriming untuk diagnosis TB. Tes HIV juga penting dilakukan pada wanita hamil terduga TB. Ibu hamil yang sakit TB, harus segera diberi pengobatan OAT untuk mencegah penularan dan kematian. Amikasin, Streptomisin, Etionamid/Protionamid **TIDAK DIREKOMENDASIKAN** untuk pengobatan tuberkulosis pada ibu hamil.

Skrinning gejala dan tanda TBC:

1. Apakah ada batuk lama (2 minggu atau lebih)?
2. Apakah ada batuk berdarah?
3. Apakah ada demam dan lemas?
4. Apakah ada berkeringat malam tanpa aktivitas?
5. Apakah terjadi penurunan berat badan tanpa penyebab yang jelas?
6. Apakah ada gejala TB Ekstra Paru (kelenjar, tulang, kulit, dll)?
7. Apakah ada kontak serumah atau kontak erat dengan pasien TB?

Apabila hasil skrining menunjukkan gejala TB, maka ibu hamil dirujuk ke Poli TB untuk tatalaksana lebih lanjut.

E. PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)

Pada masa kehamilan Program PTM terkait ada 3 penyakit, yaitu:

1. Antenatal Dengan Riwayat Hipertensi

Hipertensi selama kehamilan tidak hanya melibatkan perempuan yang hipertensi saat hamil, tetapi juga perempuan yang memiliki riwayat hipertensi sebelumnya atau mengalami hipertensi pada kehamilan sebelumnya.

Pada ibu hamil dilakukan skrining untuk menentukan stratifikasi faktor risiko hipertensi pada kehamilan dan rencana penanggulangannya. Skrining hipertensi pada ibu hamil dapat menggunakan tabel dibawah ini :

Tabel 4. Skrining Pre Eklamsi Pada Usia Kehamilan < 20 Minggu

Kriteria	Risiko Sedang	Risiko Tinggi
Anamnesis		
Multipara dengan kehamilan oleh pasangan baru		
Kehamilan dengan teknologi reproduksi berbantu: bayi tabung, obat induksi ovulasi		
Umur ≥ 35 tahun		
Nulipara		
Multipara yang jarak kehamilan sebelumnya > 10 tahun		
Riwayat preeklampsia pada ibu atau saudara perempuan		
Obesitas sebelum hamil (IMT > 30 kg/m ²)		
Multipara dengan riwayat preeklampsia sebelumnya		
Kehamilan multiple		
Diabetes dalam kehamilan		
Hipertensi kronik		
Penyakit ginjal		
Penyakit autoimun		
Keguguran berulang (APS), riwayat IUFD		
Pemeriksaan fisik		
Mean Arterial Pressure (MAP) ≥ 90 mmHG		
Proteinuria (urin celup $> +1$ pada 2 kali pemeriksaan berjarak 6 jam atau segera kuantitatif 300 mg/24 jam)		

Keterangan sistem skoring:

Ibu hamil dilakukan rujukan bila ditemukan sedikitnya:

2 risiko sedang dan atau,1 risiko tinggi

Skrining preeklamsi dilakukan pada kehamilan <20 minggu dan tetap dilakukan apabila ibu hamil K1 nya pada kehamilan >20 minggu. Rekomendasi tata laksana hipertensi pada kehamilan merujuk pada PNPK komplikasi kehamilan.

Skrining preeklampsia selama masa kehamilan wajib dilakukan pada layanan kesehatan primer. Skrining ini dimulai dari penilaian tekanan darah selama masa kehamilan dan dicatat pada lembar grafik evaluasi kehamilan pada buku KIA. Setiap ibu hamil melakukan asuhan antenatal, catat tanggal dan hasil pemeriksaan tekanan darah di kolom yang tersedia. Perhitungan *mean arterial pressure* (MAP) harus dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan tekanan darah. Jika hasil MAP lebih dari 90 maka risiko preeklampsia meningkat dan lakukan rujukan. Jika didapatkan tanda centang di dua kotak kuning dan atau 1 kotak merah maka ibu berisiko mengalami preeklamsia dan lakukan segera rujukan ke dokter spesialis obsgin.

2. Antenatal Dengan Riwayat Diabetes

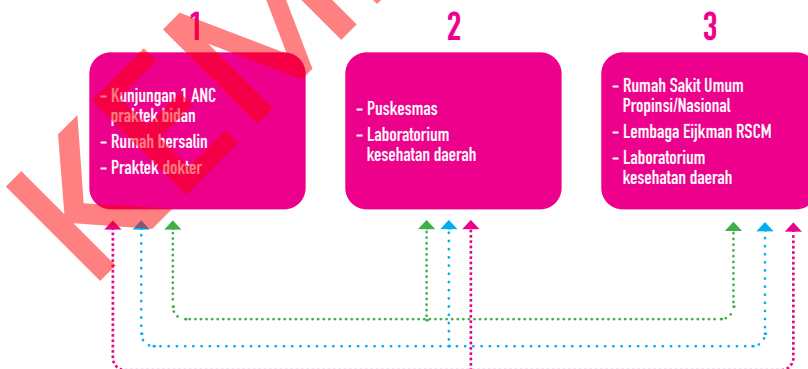
Hiperglikemia yang terdeteksi pada kehamilan harus ditentukan klasifikasinya sebagai salah satu di bawah ini:

- a. Diabetes mellitus tipe 2 dengan kehamilan atau
- b. Diabetes mellitus gestasional

3. Antenatal Dengan Riwayat Thalasemia

Setiap pasangan yang memiliki sifat atau riwayat keluarga Thalassemia, dan berencana memiliki anak dianjurkan untuk melakukan skrining. Pada kehamilan, penjarangan atau skrining utama ditujukan pada ibu hamil saat pertama kali kunjungan ANC. Jika ibu merupakan pembawa sifat atau "*carrier*" Thalassemia, maka skrining kemudian dilanjutkan pada ayah janin dengan teknik yang sama. Jika ayah janin normal maka skrining janin (pranatal diagnosis) tidak disarankan. Jika ayah janin merupakan pengidap atau "*carrier*" Thalassemia maka disarankan mengikuti konseling genetik dan jika diperlukan melanjutkan pemeriksaan skrining pada janin (pranatal diagnosis). Pemeriksaan bayi baru lahir tidak umum dilakukan tetapi dapat dilakukan bila kedua orangtuanya adalah pembawa sifat Thalassemia. Untuk pasangan dengan yang salah satunya "*carrier*", atau keduanya "*carrier*" atau salah satunya penyandang atau keduanya penyandang diberikan edukasi komprehensif tentang kondisi yang mungkin dialami oleh anak yang akan dilahirkan. Diagnosis Prenatal adalah kegiatan pemeriksaan yang bertujuan mendiagnosis janin apakah menderita Thalassemia mayor/minor/normal. Pemeriksaan ini hanya dilakukan pada janin dari pasangan yang keduanya adalah pembawa sifat Thalassemia.

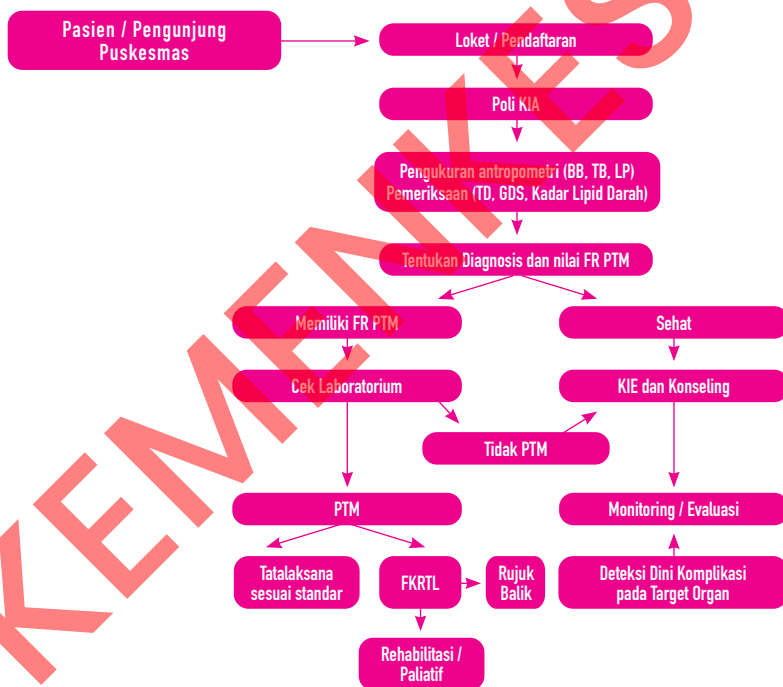
BAGAN 7. ALUR PEMERIKSAAN LABORATORIUM DARAH



Pada kasus ini selain anamnesis dan pemeriksaan fisis, pemeriksaan laboratorium tahap awal yang dapat dilakukan adalah:

1. Pemeriksaan darah: Haemoglobin, Hematokrit, MCV, MCH, RDW dan morfologi sel darah merah (sediaan hapus darah tepi).
2. Bila tidak ada fasilitas cell counter dapat dilakukan pemeriksaan Haemoglobin, Hematokrit, dan morfologi sedarah merah dengan sediaan hapus (hitung sel darah merah) untuk secara manual menghitung MCV dan MCH.

BAGAN 8. ALUR PELAYANAN TERPADU PTM DI PUSKESMAS/FKTP



F. KESEHATAN JIWA

Ibu hamil yang sehat mentalnya merasa senang dan bahagia, mampu menyesuaikan diri terhadap kehamilannya sehingga dapat menerima berbagai perubahan fisik yang terjadi pada dirinya, dan dapat tetap aktif melakukan aktivitas sehari-hari.

Masalah atau gangguan kesehatan jiwa yang dialami oleh ibu hamil tidak saja berpengaruh terhadap ibu hamil tersebut, tetapi mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janinnya saat didalam kandungan, setelah melahirkan, bayinya, masa kanak-kanak dan masa remaja.

Beberapa masalah dan gangguan kesehatan jiwa pada ibu hamil yang dapat terjadi antara lain:

1. Stres

Pada umumnya, tubuh akan bereaksi terhadap setiap situasi yang tidak menyenangkan. Stres bersifat positif dan negatif, stres yang negatif (*distress*) pada ibu hamil akan mempengaruhi suasana perasaan, perilaku dan dapat menimbulkan keluhan fisik yang membuat ibu hamil menderita jika stres tidak dikelola.

2. Gangguan Kecemasan Menyeluruh

Seringkali suasana perasaan kuatir berlebihan terhadap hal yang kecil-kecil yang tidak dapat dikendalikan, gelisah, tegang, mudah tersinggung, sulit konsentrasi berlebihan dan sulit untuk menenangkan diri disertai gejala fisik seperti gejala otonom berlebihan, ketegangan motorik, mudah lelah, dan mengalami gangguan tidur yang dialami hampir setiap hari.

3. Gangguan Panik

Rasa gelisah luar biasa yang muncul tiba-tiba tanpa alasan yang jelas dan mengalami gejala fisik seperti jantung berdebar, nafas tersengal, leher rasa tercekak, otot tegang, pusing atau sakit kepala, berkeringat bisa sampai nyeri dada dan kram otot kaki dan tangan bisa sampai kesemutan. Serangan ini berulang beberapa kali dalam sebulan dan berlangsung dalam beberapa menit.

4. Gangguan Obsesif Kompulsif (OCD)

Gangguan ini mempengaruhi pikiran dan perilaku berulang pada ibu hamil yang disadari namun sulit dikendalikan. Pikirannya terobsesi pada sesuatu hal secara terus menerus dan merasa tidak nyaman atau tertekan jika pikiran obsesifnya tidak dilaksanakan secara berulang-ulang sebagai respon terhadap kecemasannya. Gejala ini ditemukan hampir setiap hari selama 2 minggu berturut-turut.

6. Gangguan Somatoform

Beberapa keluhan fisik disertai dengan permintaan pemeriksaan medis berulang meskipun tidak ditemukan adanya kelainan dan tidak mau mendengarkan penjelasan dokter.

7. Gangguan Stres Paska Trauma

Bisa dialami ibu hamil 6 bulan setelah kejadian traumatik, dengan gejala stres, kilas balik terhadap peristiwa traumatik dan menghindari tempat atau pengalaman kejadian.

8. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan NAPZA

Menggunakan zat psikoaktif hingga menimbulkan ketergantungan, merugikan ibu hamil dan janinnya, mengalami putus zat jika berhenti dan jika penggunaan berlebihan dapat menimbulkan perubahan kesadaran dan sebagainya. Ada juga ibu hamil yang merokok dan atau minum alkohol yang tidak baik bagi kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya.

9. Gangguan Depresi

Pada kondisi ini, ibu hamil bisa mengalami suasana perasaan sedih, hilang minat, mudah lelah, sulit konsentrasi, gangguan pola makan, gangguan tidur, merasa tidak berharga, harga diri rendah, rasa bersalah, tidak berguna, suram, putus asa bahkan jika depresi berat bisa sampai ada ide atau pikiran ingin bunuh diri yang dialami selama 2 minggu berturut-turut.

10. Gangguan Skizofrenia

Pada ibu hamil terdapat gangguan pikiran, perasaan dan perilaku yang tidak serasi, sulit dirabarasakan dan tidak dapat menilai realitas (merasa pikirannya tersiar keluar, menggema atau dimasukkan dari luar). Penampilan ibu hamil umumnya tidak merawat diri, kurang kooperatif, ekspresinya tumpul atau datar, suasana perasaannya sulit dirabarasakan dan tidak serasi. Ibu hamil tidak dapat tidur, dapat mengalami halusinasi suara, dan atau mempunyai keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak dapat dikoreksi (waham).

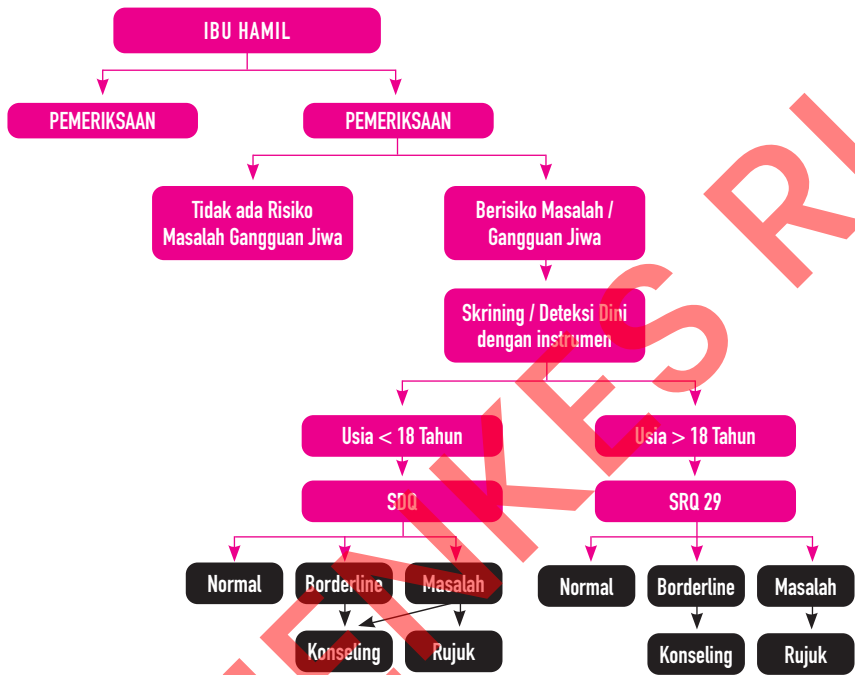
Faktor risiko gangguan kesehatan jiwa pada ibu hamil merupakan pengaruh dari faktor biologis, psikologis dan sosial antara lain: (1) riwayat gangguan mental sebelum hamil yang tidak tuntas pengobatannya, (2) kehamilan karena perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, tidak diinginkan, dan kehamilan dini diusia remaja, (4) pernikahan terpaksa atau karena hamil, dijodohkan, atau terlalu dini, (5) peristiwa traumatik saat kehamilan kekerasan seksual, (6) faktor sosioekonomi seperti kurangnya dukungan suami, keuangan, orang tua tunggal, (7) penggunaan obat, merokok, alkohol, NAPZA (8) penyakit fisik kronis (9) retardasi mental, (10) disabilitas fisik, mental dan sebagainya.

Pemeriksaan kesehatan jiwa pada ibu hamil yang dapat dilaksanakan saat melaksanakan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan primer sebagai berikut:

- Melaksanakan skrining (deteksi dini) masalah kesehatan jiwa pada ibu hamil saat pemeriksaan kehamilan melalui wawancara klinis. Jangan lupa menanyakan faktor risiko gangguan kesehatan jiwa, riwayat masalah kesehatan jiwa yang pernah dialami dan penggunaan NAPZA. Pemeriksaan kesehatan jiwa pada ibu hamil minimal dilakukan pada trimester pertama dan trimester ketiga. Apabila pada trimester pertama ditemukan masalah/gangguan jiwa, maka akan dievaluasi setiap kunjungan.
- Jika gangguan jiwa tidak dapat ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan primer, segera merujuk ke RS atau ahli jiwa di wilayah kerja fasilitas pelayanan kesehatan primer.
- Kelola stres dengan baik dengan cara: rekreasi, senam ibu hamil, jalan sehat, relaksasi, curhat dengan orang yang tepat, makanan berserat, berpikir positif, kurangi tuntutan diri sendiri, ekspresikan stres, duduk santai, tidak membandingkan diri dengan orang lain, menghitung anugrah, melatih pernafasan, mendengarkan musik dan sebagainya.
- Mempromosikan gaya hidup Ceria yaitu cerdas intelektual, emosional dan spiritual, empati dalam berkomunikasi yang efektif, rajin beribadah sesuai agama dan keyakinan, interaksi yang bermanfaat bagi kehidupan, asih, asah dan asuh tumbuh kembang dalam keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian fasilitas pelayanan kesehatan primer sedini mungkin mempersiapkan kondisi kejiwaan ibu hamil agar tetap sehat selama masa kehamilan, melahirkan bayi dan ibu yang sehat paska melahirkan.

BAGAN 9. ALUR PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA IBU HAMIL



Pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan pada pemeriksaan ANC meliputi pemeriksaan rutin dan atas indikasi. Adapun tes laboratorium yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal adalah:

- Pada indikator pelayanan Kesehatan ibu hamil: tes kehamilan, kadar hemoglobin darah, golongan darah.
- Pada indikator pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV): tes HIV.

G. IMUNISASI

Pada kehamilan terdapat perubahan pada seluruh tubuh wanita, termasuk pada sistem imun. Perubahan ini menyebabkan ibu hamil rentan terkena infeksi. Oleh karena itu perlindungan sangat penting diberikan pada kehamilan untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas ibu hamil dan janin yang dikandungnya.

Imunisasi merupakan upaya pencegahan penyakit yang paling cost effective. Pemberian imunisasi pada ibu hamil dapat dilakukan atas pertimbangan manfaat dan risiko yang diperoleh terhadap ibu dan janin jika tidak dilindungi dengan imunisasi. Manfaat dari imunisasi bagi ibu hamil lebih besar dari risiko ketika kecenderungan terhadap paparan penyakit lebih besar. Infeksi pada ibu hamil dapat menimbulkan risiko bagi ibu dan janin, sehingga pemberian imunisasi yang aman penting untuk diberikan.

Vaksin virus inaktif dan vaksin bakteri inaktif atau toksoid dapat diberikan pada masa kehamilan. Pemberian imunisasi umumnya aman diberikan pada ibu hamil, diantaranya vaksin tetanus dan difteri toksoid (Td). Imunisasi bermanfaat untuk melindungi kesehatan wanita sebelum, selama dan setelah kehamilan. Imunisasi pada kehamilan juga dapat melindungi bayi yang sedang dikandungnya dari penyakit, terutama pada bulan – bulan pertama kehidupan sampai bayi tersebut mendapatkan imunisasi sesuai dengan jadwalnya. Hal ini dapat terjadi karena pada saat kehamilan terjadi proses transfer IgG maternal dari ibu ke janin. Adanya transmisi immunoglobulin pada ibu ke janin menjadi prinsip yang mendasari pemberian imunisasi pada ibu hamil untuk memberikan perlindungan bagi bayinya.

Selain itu, seluruh dunia termasuk Indonesia juga telah menyatakan komitmen untuk mencapai eliminasi tetanus maternal dan neonatal (MNTE) yaitu penurunan angka insiden tetanus maternal dan neonatal menjadi kurang dari 1 per 1000 kelahiran hidup per tahun di tingkat kabupaten. Indonesia telah berhasil mencapai status eliminasi tetanus maternal dan neonatal pada tahun 2016. Pencapaian ini harus senantiasa dipertahankan melalui pemberian imunisasi tetanus pada bayi, baduta, anak sekolah dan wanita usia subur. Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan imunisasi, wanita usia subur (WUS) termasuk calon pengantin dan ibu hamil wajib mendapatkan imunisasi Td apabila setelah dilakukan skrining status T pada saat kunjungan antenatal belum mencapai status T5. Pemberian vaksin Td selama kehamilan efektif untuk melindungi ibu dan janin terhadap penyakit tetanus dan difteri. Antigen tetanus toksoid bermanfaat untuk mencegah tetanus maternal pada ibu dan tetanus neonatorum pada bayi yang dilahirkannya. Pemberian imunisasi Td juga terbukti aman dan tidak bersifat teratogenik.

BAGAN 10. TABEL JADWAL PEMBERIAN IMUNISASI TETANUS DI INDONESIA

Jenis Vaksin	Jadwal	Kegiatan
DTP-HepB-Hib (Pentavalent)	- Usia 2 bulan : DPT-HB-Hib 1 - Usia 3 bulan : DPT-HB-Hib 2 - Usia 4 bulan : DPT-HB-Hib 3 - Usia 18 bulan : DPT-HB-Hib 4	Imunisasi dasar dan lanjutan
DT	Kelas 1 SD atau yang sederajat	Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
Td	Kelas 2 dan 5 SD atau yang sederajat	Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
Td	Wanita usia subur termasuk Ibu hamil*	Imunisasi pada calon pengantin (catin), kunjungan antenatal, dll

Catatan:

*sebelum pemberian imunisasi Td pada WUS termasuk ibu hamil harus dilakukan skrining status T terlebih dahulu. Pemberian imunisasi Td dilakukan apabila belum mencapai status T5

Skrining Status T

Skrining dilakukan berdasarkan riwayat imunisasi yang tercatat maupun ingatan.

- Apabila data imunisasi tercatat pada buku imunisasi atau buku KIA maka riwayat imunisasi T dapat diperhitungkan
- Bila hanya berdasarkan ingatan, skrining dapat dimulai dengan pertanyaan imunisasi saat di sekolah (BIAS) untuk ibu yang lahir pada dan setelah tahun 1977. Untuk ibu yang lahir sebelum tahun 1977 langsung dimulai dengan pertanyaan imunisasi saat catin dan hamil.

Penentuan status Imunisasi T dilakukan dengan prinsip jumlah yang diberikan dan interval pemberian sebagai berikut:

Status T	Interval minimal pemberian	Masa Perlindungan
T1	-	-
T2	4 minggu setelah T1	3 tahun
T3	6 bulan setelah T2	5 tahun
T4	1 tahun setelah T3	10 tahun
T5	1 tahun setelah T4	Lebih dari 25 tahun

Contoh penentuan status imunisasi T sebagai berikut:

Anamnesa	Status T	Pemberian imunisasi Td
Belum pernah mendapat imunisasi yang mengandung T sama sekali	T0	Diberikan imunisasi pada kunjungan K1, kemudian diberikan kembali dengan interval minimal 4 minggu dan 6 bulan
Pernah mendapat imunisasi yang mengandung T satu kali	T1	Diberikan imunisasi pada kunjungan K1, kemudian diberikan kembali dengan interval 6 bulan
Pernah mendapat imunisasi yang mengandung T dua kali dengan interval minimal 4 minggu	T2	Diberikan imunisasi pada kunjungan K1
Pernah mendapat imunisasi yang mengandung T tiga kali dengan interval minimal yang sesuai	T3	Diberikan imunisasi pada kunjungan K1
Pernah mendapat imunisasi yang mengandung T empat kali dengan interval yang sesuai	T4	Diberikan imunisasi pada kunjungan K1
Sudah mendapat imunisasi yang mengandung T sebanyak 5 kali dengan interval yang sesuai	T5	Tidak perlu diberikan imunisasi

H. KECACINGAN

Infeksi cacing atau cacingan pada ibu hamil dapat menimbulkan gangguan gizi berupa kekurangan kalori dan protein serta kehilangan darah (anemia), hal ini akan mengakibatkan terjadinya hambatan perkembangan fisik pada calon bayi, bayi dengan berat lahir rendah bahkan terjadinya komplikasi pendarahan disaat melahirkan yang diakibatkan karena anemia kronis. Ada tiga jenis cacing yang umumnya menginfeksi manusia dan memberikan dampak yaitu: *Ascaris lumbricoides* (cacing gelang), *Ancylostoma duodenale* (cacing tambang) dan *Trichiuris trichiura* (cacing cambuk).

Penanggulangan Cacingan dimulai dengan mengurangi prevalensi infeksi cacing dengan membunuh cacing tersebut melalui pengobatan untuk menekan intensitas infeksi (jumlah cacing per orang), sehingga dapat memperbaiki tingkat anemia. Namun, pengobatan Cacingan harus disertai dengan upaya berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), sanitasi lingkungan serta asupan makanan bergizi.

Program Penanggulangan Cacingan pada Ibu Hamil:

1. Ibu hamil dengan pemberian Fe masih tetap anemia dilakukan pemeriksaan tinja. Jika hasil positif diberikan obat cacing secara selektif.
2. Skrining (pemeriksaan tinja) bagi ibu hamil yang mengalami gejala Cacingan atau anemi pada saat kunjungan Antenatal dan hasil pemeriksaan tinjanya positif Cacingan diberikan obat cacing secara selektif.
3. Ibu hamil yang mempunyai hasil positif (+) pada pemeriksaan tinja maka pemberian obat cacing dapat dilakukan mulai trimester ke 2 dan ke 3 dibawah pengawasan dokter.



BAB 4: PENCATATAN DAN PELAPORAN



A. PENCATATAN

Pencatatan pelayanan antenatal terpadu menggunakan formulir yang sudah ada, yaitu:

1. Kartu Ibu atau rekam medis lainnya dengan nomor KTP/NIK yang disimpan di fasilitas kesehatan
2. Kohort ibu: merupakan kumpulan data-data dari kartu ibu
3. Buku KIA (Lembar ibu)
4. Pencatatan dari program yang sudah ada (catatan imunisasi, malaria, gizi, KB, TB, *triple* eliminasi dan lain-lain)

Formulir harus diisi lengkap setiap kali selesai memberikan pelayanan. Dokumen ini harus disimpan dan dijaga dengan baik karena akan digunakan pada kontak berikutnya. Pada keadaan tertentu, dokumen ini diperlukan untuk kegiatan audit medik, atau keperluan program lainnya.

Pada program TB pengelola programnya akan mengambil pencatatan terkait jumlah ibu hamil yang diperiksa TB (dilakukan skrining) yang nantinya dibandingkan dengan target ibu hamil berdasarkan data dari KIA dan jumlah ibu hamil yang positif TB serta diberikan pengobatan.

Pada program HIV pengelola programnya akan mengambil pencatatan terkait jumlah ibu hamil yang diperiksa HIV (dilakukan skrining) yang nantinya dibandingkan dengan target ibu hamil berdasarkan data dari KIA dan jumlah ibu hamil yang positif HIV serta diberikan pengobatan.

Pada program malaria pengelola programnya akan mengambil pencatatan terkait jumlah ibu hamil yang diperiksa malaria (dilakukan skrining) yang nantinya dibandingkan dengan target ibu hamil berdasarkan data dari KIA dan jumlah ibu hamil yang positif malaria serta diberikan pengobatan.

Pelaksanaan teknis surveilans gizi dapat menggunakan sistem informasi gizi berbasis teknologi informasi yang disebut Sistem Informasi Gizi Terpadu atau Sigizi Terpadu. Dalam Sigizi Terpadu terdapat beberapa modul terbagi berdasarkan tingkat atau kewenangan pengguna baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Puskesmas dan Posyandu, yang terdiri atas: Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM), laporan rutin, distribusi makanan tambahan dan ePPGBM *offline*.

B. PELAPORAN

Pelaporan pelayanan antenatal terpadu menggunakan formulir pelaporan yang sudah ada, yaitu:

1. Laporan Bulanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak
2. Laporan Bulanan Pengendalian Penyakit Menular
3. Laporan PWS KIA
4. Laporan PWS Imunisasi
5. Untuk lintas program terkait, pelaporan mengikuti formulir yang ada pada program tersebut (ePPGBM, SIHA, SITT, SISMAL).

Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan antenatal di wilayah kerja Puskesmas melaporkan rekapitulasi hasil pelayanan antenatal terpadu setiap awal bulan ke Puskesmas atau disesuaikan dengan kebijakan daerah masing-masing.

Puskesmas menghimpun laporan rekapitulasi dari tenaga kesehatan di wilayah kerjanya dan memasukkan ke dalam register KIA untuk keperluan pengolahan dan analisa data serta pembuatan formulir laporan yang sudah ada.

Hasil pengolahan dan analisa data dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setiap bulan. Sementara itu grafik PWS KIA digunakan oleh Puskesmas untuk memantau pencapaian target dan melihat tren pelaksanaan pelayanan antenatal terpadu serta digunakan untuk pertemuan dengan lintas sektor.

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menghimpun hasil pengolahan dan analisa data dari seluruh Puskesmas di wilayahnya untuk keperluan pengolahan dan analisa data serta pembuatan grafik PWS KIA tingkat kabupaten/kota setiap bulan.

Hasil pengolahan dan analisa data dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi setiap bulan. Sementara itu grafik PWS KIA digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memantau pencapaian target dan melihat tren pelaksanaan pelayanan antenatal terpadu.

Dinas Kesehatan Provinsi menghimpun hasil pengolahan dan analisa data dari seluruh kabupaten/kota di wilayahnya untuk keperluan pengolahan dan analisa data.

Hasil pengolahan dan analisa data dilaporkan ke Pusat Data dan Surveilans Kementerian Kesehatan dengan tembusan ke Direktorat Kesehatan Keluarga setiap bulan. Sementara itu grafik PWS KIA digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk memantau pencapaian target dan melihat tren pelaksanaan pelayanan antenatal terpadu.

Pusat Data dan Surveilans Kementerian Kesehatan bersama dengan Direktorat Kesehatan Keluarga menghimpun hasil pengolahan dan analisa data dari seluruh provinsi per kabupaten/kota. Sementara itu melalui Direktorat Kesehatan Keluarga memberikan umpan balik ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melalui Gubernur.

Lintas program yang terkait pelayanan antenatal terpadu bertanggung jawab untuk melaporkan rekapitulasi hasil pelayanan ke penanggung jawab program masing-masing secara berjenjang (dari Puskesmas sampai pusat) dan memberikan tembusan ke penanggung jawab program KIA.

BAB 5:

PENUTUP

Pelayanan antenatal terpadu merupakan pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal yang berkualitas. Tujuannya adalah agar setiap ibu hamil mampu menjalani kehamilan yang sehat dan positif, bersalin dengan selamat dan melahirkan bayi yang sehat. Pelayanan antenatal terpadu mencakup pelayanan promotif dan preventif sekaligus kuratif dan rehabilitatif. Layanan ini meliputi pelayanan KIA, gizi, pengendalian penyakit menular (imunisasi, HIV/AIDS, TB, malaria, penyakit menular seksual) penyakit tidak menular (hipertensi, diabetes mellitus), ibu hamil yang mengalami kekerasan selama kehamilan serta program spesifik lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Setiap tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta diharapkan memberikan pelayanan yang komprehensif terhadap ibu hamil agar dapat memastikan kehamilan berlangsung normal, mendeteksi dini masalah dan penyakit yang dialami ibu hamil, melakukan intervensi secara adekuat, mencatat dan melaporkannya secara berjenjang dan sistematis. Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu merupakan pedoman yang dinamis, sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan program dan kebutuhan spesifik daerah.

LAMPIRAN

KEMENKES RI



LAMPIRAN DAFTAR TILIK ANTENATAL

TABEL 1. DAFTAR TILIK KEGIATAN ANAMNESIS

ANAMNESIS

Kontak ke	K1	K2	K3	K4	K5	K6
Usia gestasi (minggu)	0-12		>12-24		>24-kelahiran	
Riwayat medis lengkap **(lihat tabel 1.1)	√					
Catatan kunjungan sebelumnya		√	√	√	√	√
Keluhan selama hamil **(lihat tabel 1.2)		√	√	√	√	√

TABEL 2. RIWAYAT MEDIS LENGKAP

ANAMNESIS

Identitas	Indikasi Merujuk ke Dokter
Nama	
NIK ibu hamil	
Pembiayaan	
NO. JKN:	
Faskes TK 1:	
Faskes Rujukan:	
Golongan darah	
Tempat Tanggal Lahir/usia	Usia <20 tahun atau >35 tahun
Pendidikan	
Pekerjaan	
Alamat rumah	
Nama suami	
Telepon	
Nomor KTP /NIK suami	
Tanggal/bulan/tahun menikah	
Kode Puskesmas domisili	
No. Registrasi Kohort Ibu	

Riwayat Kehamilan Sekarang	Indikasi Merujuk ke Dokter
Jumlah kehamilan/persalinan/abortus	
Hari pertama haid terakhir/siklus haid	Lupa/tidak tahu
Taksiran waktu persalinan	Usia gestasi dari HPHT > 40 minggu
Perdarahan pervaginam	Ya
Keputihan	Ya
Mual/muntah	• Tidak bisa makan • Berat badan turun terus
Masalah/keluhan/kelainan dalam kehamilan	Ketuban pecah sebelum waktunya
Pemakaian obat/jamu	Jika belum terbukti aman bagi ibu hamil atau kekhawatiran adanya efek pada janin maupun ibu

TABEL 2. (LANJUTAN)

Riwayat Kontrasepsi	Indikasi Merujuk ke Dokter
Kontrasepsi yang digunakan (dahulu, sebelum hamil ini)	

TABEL 3. RIWAYAT MEDIS LENGKAP (LANJUTAN)

Riwayat Obstetri Lalu	Indikasi Merujuk ke Dokter
Jumlah kehamilan/persalinan/abortus	Riwayat IUFD atau <i>stillbirth</i>
Jumlah anak (tanggal lahir, jenis kelamin, usia gestasi, cara persalinan, penolong, berat lahir, panjang lahir)	• Grandemultipara • Riwayat BBL <2500gram atau >4000gram • Riwayat prematur
Keguguran (tahun, usia gestasi, sebab)	Keguguran $\geq 3 \times$ berturut-turut
Perdarahan pada kehamilan/persalinan/nifas	Ya
Hipertensi pada kehamilan/nifas	Ya
Kehamilan sungsang/letak lintang/oblik	Ya
Kehamilan ganda	Ya
Pertumbuhan janin terhambat	Ya
Penyakit dan kematian perinatal/neonatal/janin	Ya
Masalah selama kehamilan/persalinan/nifas	Ya
IMD/ASI eksklusif/cara pemberian ASI	
Tempat dan penolong persalinan terdahulu	

Riwayat Medis Lainnya	Indikasi Merujuk ke Dokter
Penyakit jantung	Ya
Hipertensi	Ya
Diabetes mellitus	Ya
Hepatitis	Ya
Suami/ibu kandung menderita Hepatitis B	Ya
HIV	Ya
Sifilis atau Infeksi Menular Seksual (IMS) lainnya	Ya
Tuberkulosis (TB)	Ya
Alergi makanan/obat	Ya
Penyakit ginjal kronik	Ya
Talasemia/gangguan hematologi lain	Ya
Malaria	Ya
Asma	Ya
Epilepsi	Ya
Riwayat gangguan kejiwaan	Ya
Riwayat operasi	Ya
Obat yang rutin dikonsumsi	Belum aman bagi ibu hamil

Status imunisasi tetanus	
Riwayat transfusi darah	Ya
Riwayat penyakit dalam keluarga (diabetes/hipertensi/ kehamilan ganda/kelainan kongenital/penyakit kejiwaan)	Ya
Riwayat kecelakaan/trauma	Ya

TABEL 4. RIWAYAT MEDIS LENGKAP (LANJUTAN)

Riwayat Sosial Ekonomi	Indikasi Merujuk ke Dokter
Usia ibu saat pertama menikah	
Status pernikahan (berapa kali menikah & lamanya)	
Respon ibu & keluarga terhadap kehamilan dan kesiapan persalinan	Negatif
Jumlah keluarga di rumah yang dapat membantu	
Pengambil keputusan dalam keluarga	
Kebiasaan/pola makan minum	
Kondisi rumah (sanitasi, listrik, alat masak)	
Kebiasaan konsumsi rokok/perokok pasif, obat, alkohol	Ya
Pekerjaan & aktivitas sehari-hari	
Pekerjaan pasangan	
Pendidikan pasangan	
Penghasilan per bulan	
Kehidupan seksual & riwayat seksual pasangan	
Pilihan tempat & penolong persalinan	
Pilihan pemberian makanan bayi	

TABEL 5. KELUHAN SELAMA HAMIL INI

Keluhan Selama Hamil	Indikasi Merujuk ke Dokter
Muntah berlebihan: tidak bisa makan dan minum? BB menurun?	Ya
Pusing/Sakit kepala berat	Ya
Perdarahan	Ya
Nyeri perut hebat	Ya
Demam lebih dari 2 hari? disertai keluarnya cairan berlebihan dari vagina?	Ya
Batuk lama lebih dari 2 minggu? Tuberkulosis? Kontak erat atau kontak serumah dengan penderita TB?	Ya
Berdebar-debar/sakit dada sampai ke punggung?	Ya
Cepat lelah (pada bulan ke-2 sampai ke-3) HB rendah?	Ya
Sesak nafas/sulit bernafas (pada bulan ke-8) mengganggu aktivitas sehari-hari?	Ya

TABEL 6. KELUHAN SELAMA HAMIL INI

Keluhan Selama Hamil	Indikasi Merujuk ke Dokter
Keputihan - warna kuning kehijauan? - berbau? - gatal?	Ya
Gerakan janin (mulai bulan ke-4) berkurang atau tidak terasa?	Ya
Perubahan perilaku - gelisah? - menarik diri? - bicara sendiri? - Tidak mau mandi?	Ya
Riwayat kekerasan terhadap perempuan gali lebih detil, gunakan pendekatan personal	Kekerasan fisik dan psikologis yang dialami secara langsung membahayakan kehamilan
Gigi dan mulut - gigi berlubang? - gusi mudah berdarah? - gusi bengkak?	Ya

TABEL 7. DAFTAR TILIK PEMERIKSAAN FISIK UMUM

Kontak ke	K1	K2	K3	K4	K5	K6	Indikasi Merujuk ke Dokter
Usia gestasi (minggu)	0-12	>12-24	>24-kelahiran				
Pemeriksaan fisik umum lengkap	√				√		Ket: dilakukan oleh dokter pada TM 1 dan TM3
Keadaan umum	√	√	√	√	√	√	- Pingsan - Kejang
Tekanan darah	√	√	√	√	√	√	- TD >140/90 - TD <90/60 - Kenaikan sistolik >30mmHg atau diastolik >15mmHg
Berat badan	√	√	√	√	√	√	- IMT >30 - BB turun >2kg/bulan pada trimester 1 - BB naik <1 kg/bulan pada trimester 2 - BB naik >2 kg/bulan pada trimester 3
Pemeriksaan terkait permasalahan pada kunjungan sebelumnya		√	√	√	√	√	Permasalahan bertambah parah atau tidak dapat diatasi
Lingkar lengan atas (LILA)	√						LILA <23,5 cm
Tinggi badan	√						TB <145 cm
Suhu tubuh	√	√	√	√	√	√	Suhu >380C
Pernafasan	√	√	√	√	√	√	Laju nafas >24x per menit atau <16x/menit

Gejala anemia (pucat, nadi cepat)	√	√	√	√	√	√	Nadi > 100x per menit atau <60x per menit
Edema	√	√	√	√	√	√	• Kaki/tangan/wajah bengkak
Tanda bahaya lain (sesak, perdarahan)	√	√	√	√	√	√	• Napas sesak saat aktivitas ringan atau duduk • Perdarahan pervaginam selama kehamilan

TABEL 8. DAFTAR TILIK PEMERIKSAAN KHUSUS OBSTETRIK-GINEKOLOGIS

PEMERIKSAAN OBSTETRIK

Kontak ke	K1	K2	K3	K4	K5	K6	Indikasi Merujuk ke Dokter
Usia gestasi (minggu)	0-12	>12-24	>24-kelahiran				
Vulva/perineum	√						• Ada massa • Keluar cairan (darah/keputihan yang tidak biasa) • Varises
Inspekulo	√						• Ada massa • Keluar cairan (darah/keputihan yang tidak biasa)
Tinggi fundus uteri (TFU) & palpasi abdomen dengan manuver Leopold: **lihat Tabel 3.1		√	√	√	√	√	• TFU > simfisis pada trimester I • TFU di bawah pusat atau <20 cm pada hamil 24 minggu • >38 cm pada trimester III
Bagian janin dengan palpasi Leopold		√	√	√	√	√	• Teraba 2 atau lebih bagian besar janin
Denyut jantung janin		√	√	√	√	√	• DJJ<110x per menit • DJJ>160x per menit • Terdengar DJJ lebih dari 1 tempat (bayi kembar)

TABEL 10. DAFTAR TILIK SKRINING PEMERIKSAAN PENUNJANG

Kontak ke	K1	K2	K3	K4	K5	K6	Indikasi Merujuk ke Dokter
Usia gestasi (minggu)	0-12	>12-24	>24-kelahiran				
Tes HIV	√	*	*	*	*	*	Reaktif
Tes Sifilis	√	*	*	*	*	*	Positif
Tes Hepatitis B	√	*	*	*	*	*	Positif
Tes malaria (khusus daerah endemis tinggi)	√	*	*	*	*	*	Positif
Golongan darah ABO dan rhesus	√						Rh (-)
Kadar glukosa darah sewaktu (jika ada riwayat Diabetes Mellitus)	*	*	√	*	*	*	>200
Kadar hemoglobin, hematocrit, leukosit, trombosit, MCH, MCV	√	*	*	*	*	√	- Hb <10 g/dl - Leukosit >18.000 sel/uL - Trombosit <150.000 sel/uL - MCV dan MCH kurang dari normal (MCV < 80 fL, MCH <27pg)
Kadar protein urin			√	*	*	*	Positif
Tes BTA	*	*	*	*	*	*	Positif
USG	√	*	*	*	*	√	Dicurigai ada kelainan
EKG	*	*	*	*	*	*	Dicurigai adanya kelainan jantung
Pemeriksaan lain sesuai indikasi	*	*	*	*	*	*	- Keton urin (+) - Glukosa urin (+)

TABEL 11. DAFTAR TILIK IMUNISASI DAN SUPLEMENTASI

Kontak ke	K1	K2	K3	K4	K5	K6
Usia gestasi (minggu)	0-12	>12-24	>24-kelahiran			
Skrining status T dan imunisasi Td sesuai status ** lihat tabel 5.1	√					
Zat besi dan asam folat (Tablet Tambah Darah)	√	√	√	√	√	√
Aspirin 80mg/ hari	*	*	*	*	*	*
Kalsium 1,5 – 2 gram/hari	*	*	*	*	*	*
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil: - Pada trimester I diberikan 2 keping biskuit lapis per hari. - Pada trimester II dan III diberikan 3 keping biskuit lapis per hari. - Tiap bungkus Makanan Tambahan (MT) ibu hamil berisi 3 keping biskuit lapis (60 gram). - Untuk ibu hamil normal, MT diberikan dengan waktu pemberian maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan edukasi. - MT Ibu Hamil ini dapat juga digunakan pada situasi darurat.	√	√	√	√	√	√

• Untuk ibu hamil KEK (LiLA < 23,5 cm) diberikan MT disertai konseling yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi ibu dengan jangka waktu pemberian MT pada ibu hamil KEK dapat lebih dari 1 bulan. • Ibu hamil harus menghabiskan MT yang diterima dan melakukan kunjungan ANC termasuk melakukan pemantauan pertambahan berat badan sesuai standar kenaikan berat badan ibu hamil dan atau LiLA.						
---	--	--	--	--	--	--

TABEL 12. PENENTUAN STATUS IMUNISASI TETANUS

Imunisasi T	Selang Waktu Minimal Pemberian Imunisasi	Indikasi Merujuk ke Dokter
T1		Langkah awal pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit
T2	1 bulan setelah T1	3 tahun
T3	6 bulan setelah T2	5 tahun
T4	12 bulan setelah T3	10 tahun
T5	12 bulan setelah T4	> 25 tahun

TABEL 13. DAFTAR TILIK PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA

PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA							
Kontak ke	K1	K2	K3	K4	K5	K6	Indikasi Merujuk ke Dokter
Usia gestasi (minggu)	0-12	>12-24	>24-kelahiran				
Penampilan umum	√	√	√	√	√	√	Tidak sesuai usia, tidak rapi/berantakan
Perilaku dan aktivitas psikomotor	√	√	√	√	√	√	• Pasif/pasif sekali • Tidak kooperatif • Agresif
Mood/Afek	√	√	√	√	√	√	Cemas/sedih/gembira berlebihan
Bicara	√	√	√	√	√	√	Tidak nyambung
Persepsi	√	√	√	√	√	√	Ada halusinasi/waham
Pikiran	√	√	√	√	√	√	• Arus pikir tidak lancar • Isi pikiran tidak sesuai realita
Fungsi kognitif	√	√	√	√	√	√	• Orientasi tempat dan waktu tidak sesuai • Daya ingat terganggu
Daya menilai realita	√	√	√	√	√	√	Tidak sesuai realita
Pengendalian impuls	√	√	√	√	√	√	Tidak terkontrol
Riwayat gangguan mental dan ataupun penggunaan NAPZA	√	√	√	√	√	√	Ya

TABEL 14. DAFTAR TILIK KOMUNIKASI, INFORMASI EDUKASI DAN KONSELING

KOMUNIKASI, INFORMASI EDUKASI DAN KONSELING

Kontak ke	K1	K2	K3	K4	K5	K6
Usia gestasi (minggu)	0-12	>12-24	>24-kelahiran			
Kesehatan ibu • Periksa hamil rutin minimal 6 kali • Cukup istirahat (malam: tidur 6-7 jam, siang: tidur/berbaring 1-2 jam) • Tidur miring ke kiri • Boleh melakukan aktivitas sehari-hari, hindari kerja berat • Boleh melakukan hubungan suami istri selama tidak ada keluhan	√	√	√	√	√	√
Perilaku hidup bersih dan sehat • Jaga kebersihan badan • Mandi 2 kali sehari menggunakan sabun • Sikat gigi sesudah sarapan dan sebelum tidur • Olah raga ringan secara teratur (jalan kaki, berenang, senam hamil) • Tidak merokok dan tidak terpapar asap rokok (perokok pasif) • Tidur dengan menggunakan kelambu terutama pada daerah endemis malaria • Tidak minum alkohol • Tidak sembarangan mengkonsumsi obat	√	√	√	√	√	√

TABEL 15. DAFTAR TILIK KOMUNIKASI, INFORMASI EDUKASI, DAN KONSELING(LANJUTAN)

KOMUNIKASI, INFORMASI EDUKASI, DAN KONSELING

Kontak ke	K1	K2	K3	K4	K5	K6
Usia gestasi (minggu)	0-12	>12-24	>24-kelahiran			
Gizi selama kehamilan: • Minum tablet tambah darah tiap hari • Prinsip gizi seimbang bagi ibu hamil • Pentingnya gizi seimbang pada ibu hamil yaitu untuk memenuhi kebutuhan ibu sendiri serta perkembangan dan pertumbuhan janin • Penambahan kebutuhan kalori dan zat gizi mikro selama hamil • Cara memilih makanan yang tepat, contoh makanan dengan gizi seimbang bagi ibu hamil (makanan utama dan selingan yang padat gizi) • Tidak ada pantangan makanan bagi ibu selama hamil, kecuali ada riwayat alergi	√	√	√	√	√	√
Tanda-tanda bahaya kehamilan • Perdarahan • Bengkak pada kaki/tangan/wajah • Sakit kepala berat, pandangan berkunang-kunang, kadang disertai kejang • Demam tinggi • Keluar air ketuban sebelum waktunya • Muntah terus menerus dan tidak mau makan • Gerakan janin berkurang atau tidak bergerak	√	√	√	√	√	√

Tanda-tanda persalinan						
• Adanya his atau rasa mulas yang teratur, semakin lama semakin sering dan semakin lama	√	√	√	√	√	√
• Keluar lender bercampur darah dari jalan lahir						
• Keluar cairan ketuban dari jalan lahir akibat pecahnya selaput ketuban						

TABEL 16. DAFTAR TILIK KOMUNIKASI, INFORMASI EDUKASI, DAN KONSELING(LANJUTAN)

KOMUNIKASI, INFORMASI EDUKASI, DAN KONSELING

Kontak ke	K1	K2	K3	K4	K5	K6
Usia gestasi (minggu)	0-12	>12-24	>24-kelahiran			
Peran suami/keluarga dalam kehamilan dan perencanaan persalinan serta antisipasi keadaan bahaya/darurat • Dukungan suami & keluarga selama hamil (suami siaga) • Persiapan biaya persalinan dan kebutuhan bayi (tabungan ibu bersalin) • Tempat persalinan • Penolong persalinan • Pendamping persalinan • Transportasi rujukan • Calon donor darah jika terjadi komplikasi	√	√	√	√	√	√
Gejala penyakit menular dan tidak menular • Jenis penyakit (HIV, AIDS, Tuberkulosis, Sifilis, dan Hepatitis B, DM, Hipertensi, Talasemia) • Cara pencegahan/pengendalian faktor risiko/ penularan • Pengaruh pada bayi • Kepatuhan minum obat • Pencegahan komorbid lainnya	√	√	√	√	√	√
Edukasi bahwa setiap ibu hamil akan dilakukan tes HIV dan Sifilis • Pentingnya tes HIV dan Sifilis • Prosedur tes HIV dan sifilis • Risiko penularan HIV dan sifilis dari ibu ke janin • Pentingnya pengobatan pada ibu terinfeksi HIV atau Sifilis • Ibu hamil yang HIV reaktif dirujuk untuk konfirmasi diagnosis HIV dan pengobatan oleh dokter. • Ibu hamil HIV mendapatkan obat ARV agar tidak menular ke bayinya, • Obat ARV saat ini diberikan gratis, asal patuh dan diteruskan seumur hidup. • Ibu HIV yang ARV lebih dari 6 bulan dapat bersalin di puskesmas oleh bidan • Ibu hamil yang Sifilis dirujuk ke dokter terapi adekuat agar tidak menular ke bayinya • Ibu Sifilis yang sudah terapi adekuat dapat bersalin di puskesmas oleh bidan	√					

Edukasi bahwa pada setiap ibu hamil akan dilakukan tes Hepatitis B (HbSag): • Pentingnya tes Hepatitis B • Prosedur tes Hepatitis B • Risiko penularan Hepatitis B dari ibu ke janin					
Edukasi tentang penanganan bayi baru lahir dari ibu terinfeksi HIV, atau Sifilis atau Hepatitis B. • Bayi dari ibu HIV mendapatkan ARV profilaksis gratis • Bayi dari ibu HIV diperiksa EID setelah usia 6 minggu disediakan pemerintah secara gratis, • Bayi dari ibu Sifilis mendapatkan profilaksis BPG gratis • Bayi dari ibu Sifilis dan ibunya diperiksa RPR pada usia 3,6,9 bulan disediakan pemerintah secara gratis, • Bayi dari ibu Hepatitis B mendapatkan profilaksis HBIG gratis sesaat setelah penyuntikan Vit K dan vaksin HB0 • Bayi dari ibu Hepatitis B diperiksa HBsAg pada usia 9-12 bulan disediakan pemerintah secara gratis,	√				
Edukasi tentang penanganan bayi bila terinfeksi HIV, atau Sifilis atau Hepatitis B. • Bayi HIV mendapatkan ARV gratis • Bayi Sifilis dirujuk ke RS untuk pengobatan tuntas • Bayi Hepatitis B dirujuk ke Spesialis Hepatologi					

TABEL 17. DAFTAR TILIK KOMUNIKASI, INFORMASI EDUKASI, DAN KONSELING(LANJUTAN)

KOMUNIKASI, INFORMASI EDUKASI, DAN KONSELING

Kontak ke	K1	K2	K3	K4	K5	K6
Usia gestasi (minggu)	0-12	>12-24	>24-kelahiran			
Inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif • Pentingnya IMD (bagi ibu dan bayi) • Prosedur IMD (skin to skin contact selama minimal 1 jam) • Kolostrum • Rawat gabung • Pentingnya ASI eksklusif • Cara pemberian ASI eksklusif (ASI saja selama 6 bulan dan dilanjutkan sampai 2 tahun) • Teknik menyusui yang benar • Perawatan puting susu				√	√	√
KB pasca persalinan • Perlunya KB pascasalin untuk mengatur kehamilan agar ibu punya waktu untuk merawat diri, anak dan keluarga • Pilihan KB pasca salin	√	√	√	√	√	√
Imunisasi • Pentingnya imunisasi Tetanus (Td) untuk mencegah ibu dan bayi mengalami tetanus neonatorum • Imunisasi Hepatitis B (HB0)<24jam dan melengkapi dosis imunisasi Hepatitis sesuai program imunisasi dasar nasional	√	√	√	√	√	√

Kekerasan pada Perempuan						
• Pengertian kekerasan pada perempuan	√	√	√	√	√	√
• Bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan						
• Akibat kekerasan pada perempuan						
• Cara pencegahan kekerasan pada perempuan						
• Cara penanganan kekerasan pada perempuan						

TABEL 18. DAFTAR TILIK KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI, DAN KONSELING(LANJUTAN)

KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI, DAN KONSELING

Kontak ke	K1	K2	K3	K4	K5	K6
Usia gestasi (minggu)	0-12	>12-24	>24-kelahiran			
Peningkatan kesehatan intelegensia bayi selama kehamilan						
• Ibu hamil perlu memberikan rangsangan auditori pada bayi sejak dini (ajak anak bicara, mendengarkan musik/lantunan ayat suci)	√	√	√	√	√	√
• Penuhi nutrisi untuk perkembangan otak bayi						
Kelas ibu hamil						
• Ikuti kelas ibu hamil jika memungkinkan						
• Bertukar pengalaman sesama ibu hamil						
• Ibu hamil membaca, memahami dan menggunakan buku KIA	√	√	√	√	√	√
• Ibu hamil membawa buku KIA pada setiap kontak dengan petugas kesehatan dan menuliskan semua hasil pemeriksaan/konseling/ rujukan pada buku KIA						
• Senam hamil						
Kesehatan Jiwa Ibu hamil						
Pengalaman dan perubahan emosi pada ibu hamil:						
• Afek	√	√	√	√	√	√
• Mood						
• Harapan						
Tanda-tanda kecenderungan mengalami <i>baby blues postpartum</i>	√	√	√	√	√	√
Kecemasan penyakit menular penyalur lain	√	√	√	√	√	√

Catatan: √=rutin dilakukan, *=dilakukan sesuai indikasi

INTEGRASI PROGRAM DALAM PELAYANAN IBU HAMIL

1. Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil

Berdasarkan data Survei Diet Total (SDT) tahun 2014 dan Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG) tahun 2016 menunjukan masih kurangnya konsumsi harian ibu hamil dari kebutuhannya berdasarkan Angka Kecukupan Gizi. Pemberian makanan tambahan atau suplementasi gizi pada ibu hamil merupakan salah satu strategi peningkatan akses pangan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan ibu hamil dalam mengatasi masalah gizi.

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil terintegrasi dengan pelayanan Antenatal Care (ANC). Pada kehamilan trimester I diberikan 2 keping biskuit lapis per hari.

Pada kehamilan trimester II dan III diberikan 3 keping biskuit lapis per hari. Tiap bungkus Makanan Tambahan (MT) ibu hamil berisi 3 keping biskuit lapis (60 gram).

Makanan Tambahan (MT) diberikan pada seluruh ibu hamil dalam rangka pencegahan ibu hamil KEK dengan waktu pemberian maksimal selama 1 (satu) bulan sebagai PMT penyuluhan disertai dengan edukasi gizi. MT Ibu Hamil ini dapat juga digunakan pada situasi darurat.

Untuk ibu hamil KEK dengan LiLA < 23,5 cm, MT dapat diberikan lebih dari 1 (satu) bulan disertai konseling yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi ibu. Ibu hamil harus menghabiskan MT yang diterima dan melakukan kunjungan pelayanan antenatal termasuk melakukan pemantauan pertambahan berat badan sesuai standar kenaikan berat badan ibu hamil dan atau LiLA.

2. Deteksi Dini Masalah Kesehatan Jiwa dengan Metode HEEADSSS

Pelayanan ibu hamil dibawah usia 18 tahun dilaksanakan di pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR) dengan metode HEEADSSS. Jika melalui deteksi dini dan wawancara klinis diduga adanya masalah kesehatan jiwa, maka dapat digunakan instrumen Strength Difficulties Questionnaire-25 (untuk usia ibu hamil dibawah 18 tahun) untuk mendeteksi cemas dan depresi jika pernyataan YA ≥ 6 . Sedangkan Self Reporting Questionnaire-29 (untuk ibu hamil diatas 18 tahun) bila pertanyaan no 1 sampai 20 terdapat ≥ 6 yang pernyataannya YA untuk cemas dan depresi, pertanyaan no 21 untuk menskrining penggunaan NAPZA, pertanyaan no 22-24 untuk menskrining gangguan psikotik, dan pertanyaan no 25-29 untuk menskrining gangguan stres paska trauma. Instrumen ini bukan instrumen diagnostik.

3. Pengelolaan Sebelum Konsepsi Pada Perempuan Diabetes Mellitus Tipe 2

Semua perempuan diabetes mellitus tipe 2 yang berencana hamil dianjurkan untuk:

- Konseling mengenai kehamilan pada DM tipe 2
- Target glukosa darah (Joslin, 2011):
 - GDP dan sebelum makan: 80-110 mg/dl
 - GD 1 jam setelah makan: 100-155 mg/dl
 - HbA1C: < 7%; senormal mungkin tanpa risiko sering hipoglikemia berulang.
 - Hindari hipoglikemia berat.
- Suplemen asam folat 800 mcg – 1 mg/hari (riwayat neural tube defect: 4 mg/hari)
- Hentikan rokok dan alkohol
- Hentikan obat-obat dengan potensi teratogenik
- Mengganti terapi anti diabetes oral ke insulin, kecuali metformin pada kasus PCOS (polycystic ovarium syndrome).
- Evaluasi retina oleh optalmologis, koreksi bila perlu
- Evaluasi kardiovaskular

LAMPIRAN TOOLS DETEKSI DINI MASALAH KEJIWAAN

usia 11-18th

SKORING DETEKSI DINI MASALAH EMOSI DAN PERILAKU DENGAN MENGGUNAKAN KUISIONER KEKUATAN DAN KELEMAHAN (STRENGTH AND DIFFICULTIES QUESTIONNAIRE-SDQ)

Untuk setiap pernyataan, beri tanda pada kotak Tidak Benar. Agak Benar atau Selalu Benar. Akan sangat membantu kami apabila kamu mau menjawab semua pernyataan sebaik mungkin meskipun kamu tidak yakin benar. Berikan jawabanmu sebagaimana sesuatu telah terjadi pada dirimu selama enam bulan terakhir.

Nama.....
Tanggal.....

Laki-laki/Perempuan

	Tidak Benar	Agak Benar	Selalu Benar
1. Saya berusaha baik kepada orang lain. Saya peduli dengan perasaan mereka (Pro)	☐ 0	☐ 1	☐ 2
2. Saya gelisah. saya tidak dapat diam untuk waktu lama (H)	☐ 0	☐ 1	☐ 2
3. Saya sering sakit kepala, sakit perut atau macam-macam sakit lainnya (E)	☐ 0	☐ 1	☐ 2
4. Kalau saya memiliki mainan, CD, atau makanan, Saya biasanya berbagi dengan orang lain (Pro)	☐ 0	☐ 1	☐ 2
5. Saya menjadi sangat marah dan sering tidak dapat mengendalikan kemarahan saya (C)	☐ 0	☐ 1	☐ 2
6. Saya lebih suka sendiri daripada bersama dengan orang yang seusiku (P)	☐ 0	☐ 1	☐ 2
7. Saya biasanya melakukan apa yang diperintahkan oleh orang lain. (C)	☐ 2	☐ 1	☐ 0
8. Saya banyak merasa cemas atau khawatir terhadap apapun (E)	☐ 0	☐ 1	☐ 2
9. Saya selalu siap menolong jika seseorang terluka, kecewa atau merasa sakit (Pro)	☐ 0	☐ 1	☐ 2
10. Bila sedang gelisah atau cemas badan saya sering bergerak – gerak tanpa saya sadari (H)	☐ 0	☐ 1	☐ 2
11. Saya mempunyai satu orang teman baik atau lebih (P)	☐ 2	☐ 1	☐ 0
12. Saya sering bertengkar dengan orang lain. Saya dapat memaksa orang lain melakukan apa yang saya inginkan (C)	☐ 0	☐ 1	☐ 2
13. Saya sering merasa tidak bahagia, sedih atau menangis (E)	☐ 0	☐ 1	☐ 2
14. Orang lain seusia saya umumnya menyukai saya (P)	☐ 2	☐ 1	☐ 0
15. Perhatian saya mudah teralih, saya sulit untuk memusatkan perhatian pada apapun (H)	☐ 0	☐ 1	☐ 2
16. Saya merasa gugup dalam situasi baru, saya mudah kehilangan rasa percaya diri (E)	☐ 0	☐ 1	☐ 2
17. Saya bersikap baik terhadap anak-anak yang lebih muda dari saya (Pro)	☐ 0	☐ 1	☐ 2
18. Saya sering dituduh berbohong atau berbuat curang (C)	☐ 0	☐ 1	☐ 2
19. Saya sering diganggu atau dipermainkan oleh anak-anak atau remaja lainnya (P)	☐ 0	☐ 1	☐ 2
20. Saya sering menawarkan diri untuk membantu orang lain (orang tua, guru, anak-anak) (Pro)	☐ 0	☐ 1	☐ 2
21. Saya berpikir terlebih dulu akibat yang akan terjadi, sebelum berbuat atau melakukan sesuatu (H)	☐ 2	☐ 1	☐ 0
22. Saya mengambil barang yang bukan milik saya dari rumah, sekolah atau dari mana saja (C)	☐ 0	☐ 1	☐ 2
23. Saya lebih mudah berteman dengan orang dewasa daripada dengan orang seusia saya (P)	☐ 0	☐ 1	☐ 2
24. Banyak yang saya takuti, saya mudah menjadi takut (E)	☐ 0	☐ 1	☐ 2
25. Saya menyelesaikan pekerjaan yang sedang saya lakukan. Saya mempunyai perhatian yang baik terhadap apapun (H)	2	1	0

Tanda tangan.....
Tanggal hari ini.....

Terima kasih banyak atas bantuan anda

INTERPRETASI DAN KESIMPULAN PEMERIKSAAN SDQ

1. SKOR KESULITAN

- a. Gejala Emosional (E)
- b. Masalah Perilaku (C)
- c. Hiperaktivitas (H)
- d. Masalah Teman Sebaya (P)

• **Menghitung Total Skor Kesulitan = Skor E + C + H + P**

• **Penilaian :**

Usia 11 - 18 tahun	
Jika Skor	
0 - 15	: Normal
16 - 19	: Ambang/Boderline
20 - 40	: Abnormal

a. Gejala Emosional/Emotional Problems (E)

- Sering mengeluh sakit pada badan (seperti sakit kepala, perut dll)
- Banyak kekhawatiran
- Sering tidak bahagia, menangis
- Gugup atau mudah hilang percaya diri
- Mudah takut

Penilaian :

Usia 11 - 18 tahun	
Jika Skor	
0 - 5	: Normal
6	: Ambang/Boderline
7 - 10	: Abnormal

b. Masalah Perilaku/Conduct Problems (C)

- Sering marah meledak-ledak.
- Umumnya berperilaku tidak baik, tidak melakukan apa yang diminta orang dewasa.
- Sering berkelahi.
- Sering berbohong, curang.
- Mencuri.

Penilaian :

Usia 11 - 18 tahun	
Jika Skor	
0 - 3	: Normal
4	: Ambang/Boderline
10	: Abnormal

c. Hiperaktivitas/Hiperactivity Problems (H)

- Gelisah, terlalu aktif, tidak dapat diam lama.
- Terus bergerak dengan resah.
- Mudah teralih, konsentrasi buyar.
- Tidak berpikir sebelum bertindak
- Tidak mampu menyelesaikan tugas sampai selesai.

Penilaian :

Usia 11 - 18 tahun	
Jika Skor	
0 – 5	: Normal
6	: Ambang/Boderline
7 - 10	: Abnormal

d. Masalah Teman sebaya (P)

- Cenderung menyendiri, lebih senang main sendiri.
- Tidak punya 1 teman baik.
- Tidak disukai anak-anak lain.
- Diganggu/digerak oleh anak lain.
- Bergaul lebih baik dengan orang dewasa daripada anak-anak.

Penilaian :

Usia 11 - 18 tahun	
Jika Skor	
0 – 3	: Normal
4 - 5	: Ambang/Boderline
6 - 10	: Abnormal

2. SKOR KEKUATAN

a. Perilaku Prososial (Pro)

- Mampu mempertimbangkan perasaan orang lain.
- Bersedia berbagi dengan anak lain. - Suka Menolong.
- Bersikap baik pada anak yang lebih muda.
- Sering menawarkan diri membantu orang lain.

Penilaian :

Usia 11 - 18 tahun	
Jika Skor	
6 – 10	: Normal
5	: Ambang/Boderline
0 – 4	: Abnormal

KUESIONER SCL-90

Nama :

Tanggal lahir :

Pendidikan/Jurusan :

Status Perkawinan :

Alamat :

Tanggal :

PETUNJUK PENGISIAN

Pernyataan-pernyataan dibawah ini merupakan keluhan atau masalah yang kadang-kadang kita alami sehari-hari. Bacalah dengan cermat, pilihlah satu nomor/angka jawaban yang anda anggap sesuai untuk menggambarkan yang sedang anda rasakan atau sedanganda hadapi dalam waktu sebulan terakhir, termasuk hari ini.

Nomor / angka jawaban :

0 = tidak sama sekali

1 = sedikit

2 = cukup

3 = agak banyak

4 = banyak

Disebelah kanan dari setiap pernyataan terdapat angka 0 - sampai dengan 4 sebagai jawaban anda (0.1.2.3.4). Lingkarilah nomor/angka yang anda pilih : bila anda ingin mengubah jawaban, hapus atau coretlah jawaban sebelumnya.

Contoh :	Anda merasakan sakit-sakit pada otot	0	1	2	3	4
----------	--------------------------------------	---	---	---	---	---

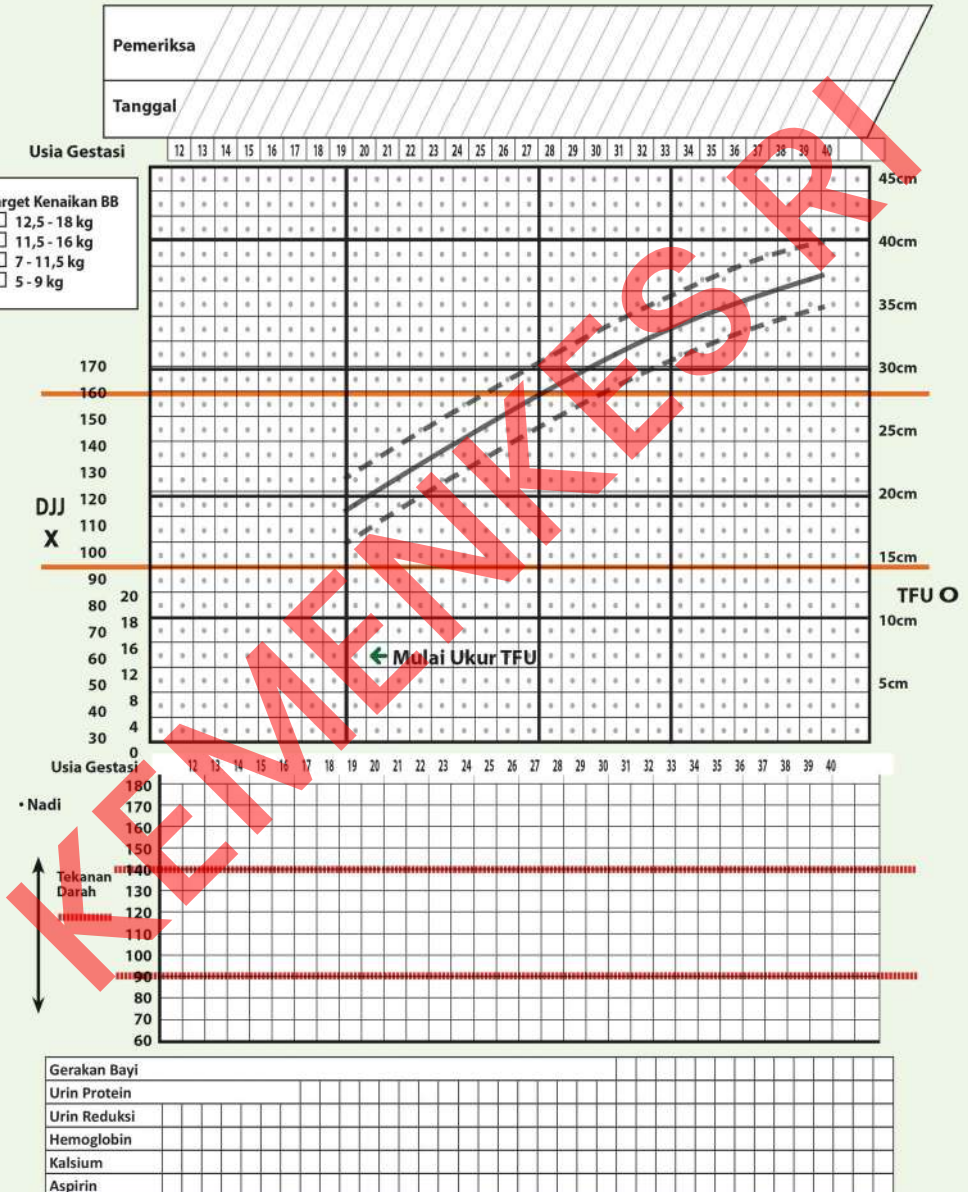
DAFTAR KELUHAN / MASALAH :						
1	Sakit kepala	0	1	2	3	4
2	Merasa gugup dan berdebar-debar	0	1	2	3	4
3	Anda mempunyai pikiran yang tidak menyenangkan, berulang - ulang	0	1	2	3	4
4	Anda merasa mau pingsan atau pusing	0	1	2	3	4
5	Anda merasa ingin mengkritik orang lain	0	1	2	3	4
6	Anda merasa ingin mengkritik orang lain	0	1	2	3	4
7	Anda merasa bahwa orang lain dapat mengontrol pikiran anda	0	1	2	3	4
8	Perasaan ingin menyalahkan orang lain untuk sebagian besar kesulitan yang anda hadapi	0	1	2	3	4
9	Anda sulit mengingat sesuatu	0	1	2	3	4
10	Anda merasa khawatir melakukan kelalaian atau hal-hal yang kotor	0	1	2	3	4
11	Perasaan anda mudah terganggu atau tersinggung	0	1	2	3	4
12	Anda mengalami rasa sakit di daerah dada / jantung	0	1	2	3	4
13	Anda merasa lemah atau menjadi lebih lamban	0	1	2	3	4
14	Anda ketakutan bila berada ditempat terbuka atau di jalan umum	0	1	2	3	4
15	Adanya pikiran untuk mengakhiri hidup	0	1	2	3	4
16	Anda mendengar suara-suara sedangkan orang lain disekitar anda tidak mendengarnya	0	1	2	3	4
17	Gemetar	0	1	2	3	4
18	Anda beranggapan bahwa orang-orang lain sebagian besar tidak	0	1	2	3	4
19	Nafsu makan anda menurun	0	1	2	3	4
20	Anda mudah menangis	0	1	2	3	4
21	Anda merasa malu atau tidak tenang dengan pria/wanita lawan jenis	0	1	2	3	4
22	Anda mempunyai perasaan bahwa anda sedang dijejek	0	1	2	3	4
23	Anda mendadak merasa takut tanpa alasan	0	1	2	3	4
24	Temperamen anda mudah meledak yan tak dapat anda kontrol	0	1	2	3	4
25	Merasa takut keluar rumah sendirian	0	1	2	3	4
26	Perasaan menyalahkan diri sendiri	0	1	2	3	4

27	Rasa sakit di daerah pinggang bawah	0	1	2	3	4
28	Anda merasa terhalang untuk menyelesaikan sesuatu	0	1	2	3	4
29	Anda merasa kesepian	0	1	2	3	4
30	Perasaan anda diliputi kesedihan	0	1	2	3	4
31	Anda mempunyai kekuatiran yang berlebihan terhadap sesuatu	0	1	2	3	4
32	Anda kehilangan minat terhadap sesuatu	0	1	2	3	4
33	Anda mudah ketakutan	0	1	2	3	4
34	Perasaan anda mudah terluka	0	1	2	3	4
35	Anda merasa pikiran-pikiran pribadi anda diketahui orang lain	0	1	2	3	4
36	Anda merasa orang lain tidak memahami anda atau anda merasa mereka tidak simpatik	0	1	2	3	4
37	Perasaan bahwa orang lain tidak ramah atau tidak menyukai anda	0	1	2	3	4
38	Anda merasa sangat lambat dalam menyelesaikan sesuatu karena menghindari kesalahan	0	1	2	3	4
39	Anda merasa debaran jantung anda kuat dan cepat	0	1	2	3	4
40	Rasa mual atau perasaan tak enak di perut	0	1	2	3	4
41	Perasaan rendah diri terhadap orang-orang lain	0	1	2	3	4
42	Anda merasakan sakit-sakit pada otot	0	1	2	3	4
43	Perasaan bahwa orang lain memperhatikan atau membicarakan Anda	0	1	2	3	4
44	Sukar tidur	0	1	2	3	4
45	Anda harus memeriksa berulang-ulang apa saja yang telah anda Kerjakan	0	1	2	3	4
46	Sukar membuat keputusan	0	1	2	3	4
47	Anda merasa takut bepergian mengendarai bis, kereta api atau pesawat terbang	0	1	2	3	4
48	Kesukaran untuk bernafas dengan lega	0	1	2	3	4
49	Rasa panas dan dingin	0	1	2	3	4
50	Kebutuhan untuk menghindari tempat, benda atau kegiatan tertentu karena hal tersebut menakutkan	0	1	2	3	4
51	Pikiran anda terasa kosong	0	1	2	3	4
52	Hilang rasa/kebas atau kesemutan pada bagian-bagian tertentu tubuh anda	0	1	2	3	4

53	Seperti ada sesuatu yang menganjal di tenggorokan	0	1	2	3	4
54	Perasaan bahwa tak ada harapan untuk masa depan	0	1	2	3	4
55	Anda sukar berkonsentrasi	0	1	2	3	4
56	Merasa lemah pada bagian tunuh tertentu	0	1	2	3	4
57	Merasa tegang atau terpaku/bengong	0	1	2	3	4
58	Kaki dan tangan terasa berat	0	1	2	3	4
59	Pikiran-pikiran tentang kematian atau akan mati	0	1	2	3	4
60	Terlalu banyak makan	0	1	2	3	4
61	Perasaan tidak tenang bila orang memperhatikan atau membicarakan anda	0	1	2	3	4
62	Anda mempunyai pikiran-pikiran yang bukan milik anda sendiri	0	1	2	3	4
63	Adanya dorongan untuk memukul, melukai, atau merugikan orang lain	0	1	2	3	4
64	Terbangun pada dini hari	0	1	2	3	4
65	Keharusan untuk mengulang-ulang tindakan yang sama, seperti menyentuh, menghitung atau mencuci	0	1	2	3	4
66	Gelisah atau merasa terganggu waktu tidur	0	1	2	3	4
67	Adanya dorongan untuk merusak atau menghancurkan barang	0	1	2	3	4
68	Pikiran atau keyakinan bahwa orang lain tak mau bekerja sama	0	1	2	3	4
69	Perasaan malu terhadap diri sendiri diantara orang-orang	0	1	2	3	4
70	Perasaan tidak tenang berada ditengah orang banyak seperti saat berbelanja atau menonton film	0	1	2	3	4
71	Perasaan bahwa segala sesuatu perlu dicapai dengan perjuangan berat	0	1	2	3	4
72	Serangan-serangan panik atau teror (ketakutan hebat)	0	1	2	3	4
73	Perasaan tidak nyaman dalam soal makan	0	1	2	3	4
74	Sering terlibat dalam oerdebatan/adu argumentasi	0	1	2	3	4
75	Gugup bila ditinggal sendirian	0	1	2	3	4
76	Orang lain kurang menghargai hal yang telah anda capai	0	1	2	3	4
77	Merasa kesepian walaupun tidak sendirian	0	1	2	3	4
78	Perasaan amat gelisah sehingga tidak dapat duduk dengan tenang	0	1	2	3	4

PELAYANAN KEHAMILAN

Diisi oleh Bidan atau Perawat

GRAFIK EVALUASI KEHAMILAN*) $MAP \approx (2 \times D) + S \text{ MAP} \approx 90$ Rujuk

GRAFIK Peningkatan Berat Badan



MINGGU KEHAMILAN

Tanda	BB Pra-Kehamilan	IMT Pra-Kehamilan	Rekomendasi Peningkatan Berat Badan
—		<18,5	12,5 - 18 kg
---		10,5 - 24,9	11,5 - 16kg
----		25,0 - 29,9	7 - 11,5 kg
=====		≥30	5 - 9 kg

METODE KONTRASEPSI	TANGGAL	RENCANA	PELAKSANAAN
25	26	27	28
Mal			
Kondom			
Pil			
Suntik			
AKDR			
Implant			
MOW			
MOP			

PEMANTAUAN PPIA (UNTUK IBU HAMIL YANG POSITIF)

HASIL DETEKSI DINI					
1. Jenis Screening Test		Tgl Screening / Test*	Kode Specimen	Hasil Screening*	
HBsAg				Reaktif	Non Reaktif
HIV				Reaktif	Non Reaktif
Sifilis				Reaktif	Non Reaktif
2. Ibu Hamil dirujuk untuk tata laksana:					
HIV		Tgl masuk PDP:		Tgl Mulai Arv:	
Sifilis		Ditangani: Ya / Tidak		Diobati Adequat: Ya / Tidak	
Hepatitis B		Dirujuk: Ya / Tidak			
3. Pasangan mengetahui status HIV : Ya / Tidak					
4. Pasangan diperiksa Sifilis : Ya / Tidak					
5. Faskes Rujukan :					

PEMANTAUAN BAYI DARI IBU HEPATITIS B

1	Tanggal / Jam Pemberian:	HBO:	HBIG:	DPT/HB1:
		DPT/HB2:	DPT/HB3:	
2	Pemeriksaan bayi (9-12 bulan):	HBsAg	Tanggal:	Hasil: Reaktif / Non Reaktif
		Anti HBs	Tanggal:	Hasil: Reaktif / Non Reaktif

PEMANTAUAN BAYI DARI IBU HIV

JENIS PEMANTAUAN	TANGGAL	HASIL	
Pemberian ARV			
DBS EID pada usia 6-8 Minggu		Reaktif	Non Reaktif
Konfirmasi EID dalam 12 bulan		Reaktif	Non Reaktif
Pemeriksaan balita terdeteksi HIV (serologis) (Bayi usia >=9 bulan atau anak balita)		Reaktif	Non Reaktif
Balita HIV masuk perawatan PDP			
Balita HIV mendapat pengobatan ARV			

PEMANTAUAN BAYI DARI IBU SIFILIS

Bayi dari ibu Sifilis dirujuk	Ya / Tidak	
Bayi <2 tahun diperiksa Sifilis	Ya / Tidak	Hasil: Reaktif/Non Reaktif

Catatan Khusus:



KARTU IBU

Nama / Kode Puskesmas :
Nomor Registrasi Ibu :

IDENTITAS IBU

Nama Lengkap Ibu	:	NIK	:	Posyandu	:
Nama Suami	:	NKK	:	Nama Kader	:
Tanggal lahir	:	Umur	:	Disabilitas	:
Alamat domisili	:	RT/RW	:	Tgl Register	:
Desa/Kelurahan	:	Kecamatan	:	Telp/HP	:
Kab/Kota	:	Provinsi	:		
Pendidikan Ibu	:	Agama	:		
Pekerjaan Ibu	:	Pembiayaan	:	JKN / Jampersal / Asuransi kesehatan lain / Mandiri	

RIWAYAT OBSTETRIK

Gravida	:	Tanggal Periksa	:	Tinggi Badan	:	cm
Partus	:	Tanggal HPHT	:	LILA	:	cm
Abortus	:	Taksiran Persalinan	:	Status Gizi	:	KEK/Normal
Hidup	:	Tgl. Persalinan Sebelumnya	:	Buku KIA	:	Memiliki/Tidak
		BB Sebelum hamil	:	Golongan Darah, Rhesus	:	A/B/AB/O Pos/Neg
		BB Saat ini	:			

Riwayat Komplikasi Kebidanan	:	
Riwayat persalinan sebelumnya	:	Prematur / BBLR / Kelainan Kongenital
Riwayat Penyakit Kronis dan Alergi	:	
Riwayat penyakit menular	:	TB / HIV / Hepatitis / Sifilis / Malaria / lainnya sebutkan:
Riwayat KB	:	

RENCANA PERSALINAN

Tanggal	Penolong		Tempat	Pendamping	Transportasi	Pendonor darah/ Gol darah	
1	2		3	4	5	6	
		Bidan	Pustu	Suami	Suami	Suami	
		Dr. Umum	Puskesmas	Keluarga	Keluarga	Keluarga	
		Dr. Spesialis	PMB	Teman	Teman	Teman	
			RSIA	Tetangga	Lain-lain	Lain-lain	
			RS	Lain-lain	Tidak ada	Tidak ada	
			Klinik	Tidak ada			

PEMERIKSAAN DOKTER TM1

PEMERIKSAAN FISIK

Konjungtiva	:	Normal / Tidak
Sklera	:	Normal / Tidak
Kulit	:	Normal / Tidak
Leher	:	Normal / Tidak
Gigi/mulut	:	Normal / Tidak

USG

GS (Gestational Sac)	:	Cm
CRL (Crown-rump-Length)	:	Cm
DJJ (denyut Jantung janin)	:	dpm
Sesuai usia kehamilan	:	mgg
Taksiran persalinan	:	

Skrining Preeklamsi	:	
KESIMPULAN	:	
REKOMENDASI	:	ANC dapat dilanjutkan di FKTP / Rujuk FKRTL

Catatan Khusus:

PERAWATAN SELAMA HAMIL (ANTE NATAL CARE OLEH BIDAN)

* : ✓ Jika ya/dilakukan
 X Jika tidak

** : ✓ Pada salah satu kolom

*** : Tulis nama obat yang diberikan

2. Status Gizi :
LILA < 23,5 cm : KEK (K)
LILA > 23,5 cm : Normal (N)

3. Kepala Terhadap PAP :
Masuk : M
Belum Masuk : BM

4. Presentasi :
KP : Kepala
BS : Bokong/Sungsang
LLO : Letak Lintang/Obligue

Obat TB :
R : Rifampisin
H : INH
Z : Pyrazinamid
E : Etahmbutol

PEMERIKSAAN DOKTER TM3

PEMERIKSAAN FISIK

USG

Rencana Konsultasi Lanjut	: Gizi / Kebidanan / Anak / Penyakit dalam / Neurologi / THT / Psikiatri / lain-lain
Rekomendasi	: ANC di FKTP / Rujuk FKTRL
Rencana Persalinan	: Normal / SC
Pilihan Rencana Kontrasepsi	: MAL / Pil / Suntik / AKDR / Implan / Steril / Belum memilih

MASA PERSALINAN

Usia Kehamilan	:	minggu
Usia HPHT	:	minggu
Keadaan Ibu	:	Hidup / Mati
Keadaan Bayi	:	Hidup / Mati
Berat bayi	:	gram
Jenis Kelamin	:	Laki / Perempuan
Panjang Bayi	:	cm

[illegible]

*** : Tulis nama obat yang diberikan

PETUNJUK PENGISIAN
REGISTER KOHORT IBU

Kode Puskesmas :
diisi nama Puskesmas sesuai dengan peraturan yang ada

Nama Puskesmas :
diisi nama Puskesmas sesuai peraturan yang ada

Desa :
diisi nama Desa/Kelurahan dilaksanakan kegiatan

Bulan :
diisi bulan peserta baru terdaftar

Tahun :
diisi tahun peserta baru terdaftar

Bidan :
diisi nama bidan penanggungjawab
pelaksanaan kegiatan di desa/kelurahan ini

Kolom 1	: Diisi Nama lengkap ibu hamil
kolom 2	: Diisi Nomor Induk Kependudukan di KTP, bila ibu tidak punya KTP diberi tanda (-)
Kolom 3	: Diisi alamat ibu hamil, desa/kelurahan
Kolom 4	: Diisi sumber pembiayaan : JKN, Jamkesda, Jampersal, Pribadi,dll
Kolom 5	: Diisi usia ibu dalam tahun
Kolom 6	: Diisi status Gravida, Partus dan Abortus
Kolom 7	: Diisi jarak kehamilan saat ini dengan kehamilan terakhir (tahun dan bulan)
Kolom 8	: Diisi tanggal taksiran persalinan (ddmmyy)
Kolom 9	: Diisi tinggi badan ibu hamil dalam cm
Kolom 10	: Diisi ukuran Lingkar lengan atas dalam cm, saat diukur pertama kali. Untuk bumil KEK hasil pemantauan LILA diisi di bulan kunjungan
Kolom 11	: Diisi status Td ibu hamil saat skrining
Kolom 12	: Diisi Tanggal pemberian Injeksi Td bila diberikan
Kolom 13	: Diisi hasil skrining anamnesa TBC (suspek atau non suspek)
Kolom 14	: Diisi hasil skrining anamnesa kesehatan jiwa
Kolom 15	: Diisi hasil pemeriksaan hemoglobin
Kolom 16	: Diisi golongan darah ibu hamil A/B/O/AB
Kolom 17	: Diisi hasil pemeriksaan proteinuri +/-
Kolom 18	: Diisi hasil pemeriksaan glukosa urin +/-
Kolom 19	: Diisi hasil pemeriksaan HIV +/-
Kolom 20	: Diisi hasil pemeriksaan Sifilis +/-
Kolom 21	: Diisi hasil pemeriksaan Hepatitis B +/-
Kolom 22	: Diisi hasil pemeriksaan TBC secara mikroskopis +/-
Kolom 23	: Diisi hasil pemeriksaan Malaria +/-
Kolom 24	: Diisi bila ada hasil pemeriksaan laboratorium yang lain
Kolom 25	: Diisi jenis konseling yang sudah diberikan
Kolom 26	: Diisi hasil skrining jenis komplikasi penyerta dalam kehamilan
Kolom 27	: Diisi tata laksana kasus untuk ibu hamil dengan risiko dan penyulit, termasuk didalamnya rujukan (ditulis tanggal dan jenis tindakan)
Kolom 28 - 39	: Diisi tanggal kunjungan dan hasil pemeriksaan (misal : BB, TFU, DJJ, Presentasi, TTD, PMT, Kelas Ibu (KI), Kelambu Malaria (KM) dll) Kinerja pelayanan K1, K4, K6, Lahir
Kolom 40	: Diisi tanggal lahir dan hasil kelahiran, hidup atau mati (maserasi atau fresh)
Kolom 41 - 42	: Diisi berat lahir bayi dalam gram
Kolom 43	: Diisi cara persalinan : normal, SC, vakum, forsep
Kolom 44	: Diisi tempat persalinan : rumah, Poskesdes, Polindes, Puskesmas, PMB, Klinik, Rumah Sakit
Kolom 45	: Diisi penolong persalinan : bidan, dokter umum, SpOG, perawat, dukun, lainnya
Kolom 46	: Diisi penyulit yang terjadi dalam proses persalinan : KPD, partus lama, distosia bahu, dll
Kolom 47 - 50	: Diisi tanggal dan pelayanan yang diberikan sesuai periode kunjungan nifas (misal : BB/TD, Pemberian Vit A)
Kolom 51	: Diisi tanggal kunjungan dan jenis metode KBPP yang dipilih : pil (P)(Non MKJP), suntik (S)(Non MKJP), implant (I)(MKJP), IUD(MKJP), Kondom (K)(Non MKJP), MOW(MKJP), MOP(MKJP), cara lain(Non MKJP)
Kolom 52	: Diisi tata laksana kasus untuk ibu nifas dengan penyulit termasuk didalamnya rujukan (ditulis tanggal dan jenis tindakan)
Kolom 53	: Diisi hal-hal lain yang penting untuk dituliskan

- Catatan :**
1. **Presentasi**
KP : Kepala
BS : Bokong/Sungsang
LLO : Letak Lintang/Oblique

2. **Status Imunisasi :**
T0, T1, T2, T3, T4, T5

3. **Lahir mati (stillbirth):**
Maserasi/Fresh



REGISTER KOHORT IBU

KODE

DESA

:

PUSKESMAS

:

KECAMATAN

:

[

]

KABUPATEN/KOTA

:

[

]

PROVINSI

:

[

]

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Kesehatan RI. (2015). Pedoman Gizi Seimbang. Jakarta
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). Petunjuk Teknis Makanan Tambahan Balita dan Ibu Hamil. Jakarta
- Kementerian Kesehatan RI. (2015). Pedoman Penanggulangan Kurang Energi Kronik (KEK) pada Ibu Hamil. Jakarta
- Kementerian Kesehatan RI. (2015). Pedoman Penatalaksanaan Pemberian Tablet Tambah Darah. Jakarta
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta
- PP POGI. Panduan Penetalaksanaan Kehamilan Dengan Diabetes Militus. Jakarta
- PP POGI. Panduan Penetalaksanaan Kehamilan Komplikasi Kehamilan. Jakarta
- World Health Organization. (2012). Guideline: Daily Iron And Folic Acid Supplementation In Pregnant Women. Geneva
- PB Perkeni. (2015). Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Di Indonesia 2015. Jakarta

KEMENKES RI



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI | 2020